

Inventario de personalidad (MMPI)

**J. Núñez de Arco M.
Verónica Viveros G.**

**Universidad del Valle
CATEDRA DE PSICODIAGNOSTICO
SUCRE 2004**

INTRODUCCIÓN

La Psicología es una Ciencia ya consolidada, que desde sus comienzos ha enfocado su interés en la investigación de lo que se denomina *Personalidad*, vocablo generador de varias definiciones, que varían según el autor y la escuela del mismo, entre ellas tenemos: “La personalidad es la suma total de todas las características físicas, mentales, emocionales y sociales. Dichas características lo diferencian de sus semejantes (...) La personalidad no es estática, se desarrolla con el transcurso de los años y siempre está en proceso de cambio”.¹ Para uno de los fundadores del conductismo, John Watson: “Es el producto final de un sistema de hábitos”.² Carmichael sostiene que la personalidad es: “La organización total de un ser humano, en cualquier fase de su desarrollo”.³ Eysenck la define como: “La suma total de las pautas actuales y potenciales de conducta del organismo, determinadas por la herencia y el medio”.⁴

Pero, ¿Cómo se podría evaluar la personalidad de los individuos, considerando la compleja dimensión de este término?. Es precisamente la aparición de instrumentos de medición psicológicos que aportaron significativamente a la científicidad y credibilidad de la Psicología. Dichos instrumentos fueron perfeccionándose en el transcurso de los tiempos, llegando a dividirse en dos grandes grupos: Proyectivos, como ser: el Test de la Figura Humana de Machover, Rorschach, H. T. P, entre otros; y los Objetivos, entre los cuales podríamos mencionar al 16 PF y el Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), que traducido al español es Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, dicho inventario ofrece una evaluación objetiva, confiable, validada y sobre todo práctica de la personalidad. El presente Manual de Interpretación del muy difundido MMPI, pretende proporcionar una guía práctica y sobretodo gráfica de cómo se evalúa e interpreta el MMPI por medio de ejemplos claves. Asimismo proporciona al lector las respectivas

¹ RICE, Phillip, *Desarrollo Humano*, PRENTICE – HALL HISPANOAMERICANA S.A, México, 1997.

² ALVARADO, José María, *“Psiquiatría Forense”*, OFFSET PRISA PUBLICIDAD, La Paz – Bolivia 1993.

³ IDEM

consideraciones éticas antes, durante y después de la aplicación de las pruebas psicológicas.

HISTORIA Inicialmente el MMPI fue desarrollado para la obtención de información clínica y diagnóstica acerca de pacientes psiquiátricos y médicos en general.⁵ Los primeros estudios se realizaron en los años 40, cuando Starke Hathaway y McKinley, empezaron a reunir rases para elaborar una técnica para la evaluación objetiva de la personalidad.⁶ utilizando preguntas frecuentes en entrevistas clínicas, neurológicas, psiquiátricas, medicina en general; escalas utilizadas en la época destinadas a la evaluación de la personalidad y escalas sobre orientación vocacional.

“Originalmente, la lista de ítems era de 1200 frases, que posteriormente se redujeron a 504. esta selección se basó, en parte, en procedimientos empíricos de análisis de ítems, cuyo objeto era de discriminar entre diferentes grupos psiquiátricos previamente diagnosticados y grupos de ‘normales’. Esta es la técnica de ‘grupos contrastados’. En 1942 Hatahway y McKinley disponían de administraciones de la técnica efectuadas a 3000 sujetos”.⁷

La elaboración de todo el inventario y la obtención de las escalas ha sido objeto de una serie de estructuras e investigaciones realizadas por los autores ya mencionados y sus colaboradores Welsh y Dahlstrom en 1956.⁸

⁴ IDEM

⁵ BRENLLA, Maria Elena *et al*, *Evaluación de la Personalidad*, PSICOTECA EDITORIAL, Argentina 1992.

⁶ IDEM

⁷ IDEM

⁸ HATHAWAY – MCKINLEY, *Cuestionario de la Personalidad MMPI*, EDICIONES TEA, España 1975.

La credibilidad y objetividad del MMPI, han garantizado su predominancia ante muchas otras pruebas o inventarios de personalidad, puesto que su presencia es casi infaltable en muchas áreas de la Psicología actual, al ofrecer mucha precisión en los resultados, puesto que las respuestas del individuo a examinar, se califican en forma objetiva ya sea manualmente o con un equipo de cómputo.⁹ La presente edición, está proyectada para proporcionar al lector una guía práctica para la administración e interpretación de este valioso instrumento de medición.

Hoy en día el MMPI II en su nueva versión, y el MMPI original, es uno de los instrumentos de medición más difundido que ha sido traducido a varios idiomas, y que su uso masivo a nivel mundial, es testigo del gran aporte que dicha prueba ofrece a todos los psicólogos en sus interpretaciones.

ALCANCES DEL MMPI

Como se mencionó anteriormente, el MMPI es de uso mundial, su objetividad y multidimensionalidad lo hacen presente en evaluaciones clínicas, laborales, forenses y educativas.

“Desde su primera edición, el MMPI ha llegado a ser uno de los instrumentos más importantes en el campo clínico y de la orientación. A partir de entonces se han llevado a cabo numerosos estudios e investigaciones, recogidos en la literatura profesional”.¹⁰

En materia forense, la validez, confiabilidad y precisión del MMPI lo hacen presente en los juicios legales más importantes de Estados Unidos y España: “...en Indiana (EE. UU), la corte de apelación en el Estado de Byrd, 579N. E. 2d 457(Ind. App. 1 Dist. 1991), permitió la introducción de resultados del MMPI, mostrando que el perfil psicológico del demandado delictivo era ‘a sabiendas’ incoherente con el requisito mental de una persona capaz de asesinar”.¹¹

⁹ GRAHAM, *MMPI Guía Práctica*, Editorial El Manual Moderno, México, 1999.

¹⁰ GRAHAM, *MMPI Guía Práctica*, Editorial El Manual Moderno, México, 1999.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

La predictibilidad clínica garantizada por el MMPI, el diagnóstico orgánico previamente realizado que se relaciona con los perfiles obtenidos con el MMPI, la similitud de resultados con otras pruebas psicológicas vigentes y de gran importancia para la ciencia psicológica como ser las láminas de tinta de Rorschach, Machover, 16 PF y otras, colocan a este inventario de personalidad como uno de los más validados y confiables, siempre presente en el psicodiagnóstico clínico en diversas partes del mundo.

ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA

Existen diferentes métodos para aplicar el MMPI, éstas varían de acuerdo al caso clínico que se pretende evaluar, las condiciones físicas del evaluado y si se pretende evaluar a una o más personas al mismo tiempo.

1. Formato individual (Tarjetas)

Llamado también la forma de *La Caja*, formato individual que fue el primero en ser diseñado. Son tarjetas individuales de 8.8 x 5.7 cm, en las que están impresas 556 frases, que el sujeto a evaluar debe separar por grupos: *Falso*, *Verdadero* y *No puedo decir*. "...es especialmente útil para individuos con capacidad, educación limitadas o ambas, que podrían tener dificultad para completar las formas de folleto (...) para personas trastornadas o confundidas que podrían equivocarse al marcar las respuestas en una hoja por separado".¹²

2. Formato colectivo (Folleto)

Este formato de grupo fue publicado más tarde, debido a las exigencias de contar con material aplicable colectivamente, para facilitar y apresurar la interpretación de los resultados. Consta de un cuadernillo o folleto en el cual están impresos los 566 reactivos, los cuales deben ser respondidos en la hoja de respuestas. Las instrucciones sobre cómo responder se encuentran en forma detallada en la primera hoja del folleto. Se debe aconsejar al examinado el leer con cuidado las

¹¹ NUÑEZ DE ARCO, Jorge, "*El informe pericial en psiquiatría forense*", MAVIA PRODUCCIONES GRAFICAS, La Paz – Bolivia 2001, Pg 137.

¹² GRAHAM, J. R., "*MMPI. Guía Práctica*", MANUAL MODERNO, México 1999.

instrucciones y seguirlas detalladamente para evitar subjetividades o malentendidos futuros a la hora de corrección de la prueba.

3. Formatos especiales.

Debido a la gran importancia del MMPI en la evaluación de la personalidad, y considerando que las anteriores formas de aplicación están pensadas para personas “normales”, se han diseñado otro tipo de formatos para personas con discapacidad, entre ellos tenemos la Forma Grabada. “...disponible para su administración a semianalfabetos y personas con otras incapacidades que hacen difícil o imposible que completen otras formas. La grabación se produce para la persona y durante una pausa después de cada reactivo, la respuesta se graba ya sea por el examinado o por el examinador...”.¹³

Es importante recalcar que el presente manual del MMPI, está diseñado y pensado sólo para la aplicación del segundo formato estudiado, es decir, del Formato Colectivo o de grupo (Folleto).

CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL EXAMINADOR

El MMPI es un inventario de personalidad que se ha afianzado un lugar importante el psicodiagnóstico a nivel mundial, es por ello que al ser una prueba tan seria e importante, se espera que la persona que lo aplique sea calificada con una preparación previa y eficiente antes de realizar informes que puedan estar errados. El especialista debe mantener las plantillas de corrección fuera del alcance de cualquier persona ajena a la profesión psicológica, puesto que de lo contrario se podrían replicar y caer en manos de gente malintencionada. Por tanto es deber y obligación mantener todo el material en un lugar seguro y confiable.

Antes de permitir que examinado comience la prueba, el examinador debe cerciorarse de que conozca la finalidad de la prueba y haya entendido

¹³ IDEM

correctamente las instrucciones. Si el examinado es menor de 18 años, se deben tener una certificación firmada que los padres o tutores han autorizado la aplicación de la prueba. Se debe evitar comentarios de cualquier tipo en contra o a favor del examinado. Mantener ante todo objetividad antes, durante y después de la prueba. El examinador debe mostrar tolerancia ante las preguntas por parte del examinado, aún cuando estas sean frecuentes. No se debe aplicar la prueba si el sujeto no habla correctamente el idioma en el que esté impreso el inventario.

En el momento de interpretar el MMPI, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: evitar ante todo el mal conteo de las respuestas, puesto que cualquier error invalidaría el perfil. Evitar etiquetar al sujeto a partir de los resultados que se vayan obteniendo. No hacer fotocopias de los materiales de evaluación (plantillas, hojas de gráficos). Evitar generalizar los resultados a otros perfiles similares.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS OBJETOS A EVALUAR

La prueba se aplica a sujetos de 18 años y / o mayores, que sepan leer fluidamente para poder entender el significado de cada reactivo y pueda relacionarlo consigo mismo. El examinador debe cerciorarse que el examinado comprendió las instrucciones sobre el registro y uso de la hoja de respuestas.

Es importante que el examinado se encuentre relativamente calmado y concentrado mientras realiza la prueba. Se deben evitar estímulos que causen ansiedad, al decir estímulos, me refiero a estímulos humanos, ya sea la madre o el padre del sujeto, los cuales pueden aparecer como agentes estresores. Otro aspecto a considerar es que el individuo que vaya a aplicar la prueba no se encuentre contaminado por los reactivos.

Se debe tomar en cuenta que muchos individuos tienen ciertas características físicas, emocionales o conductuales que pueden invalidar la prueba o demorarla, entre ellas se puede citar: Distracción originada por algún acontecimiento traumático anterior a la prueba, intoxicación por drogas o alcohol, resistencia a la prueba, distracción extrema originada por una reacción maníaca, tics de origen nervioso,

problemas visuales o auditivos, dislexia o afasia, retardo mental, desorientación en el tiempo y el espacio, etc.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL AMBIENTE

Como todas las pruebas psicológicas la aplicación del MMPI se requiere también de un ambiente ideal para evitar que el evaluado aplique la prueba en ambiente ansiógeno perjudicando el buen desarrollo de la prueba. Debe ser un lugar tranquilo, libre de estímulos y distracciones, que tenga buena iluminación y que sea ventilado. La mesa donde se lleva a cabo la lectura y respuesta de los reactivos, debe ser lo suficientemente amplia para soportar convenientemente la hoja de respuestas y el folleto.

INVALIDEZ DE LA PRUEBA

Cualquier falta a las condiciones anteriormente descritas podría invalidar la prueba. Se debe considerar que el tiempo de aplicación varía de 45 a 60 minutos, relacionando el incremento del mismo con la cultura del sujeto y la resistencia del mismo sentirse examinado, puesto que se observan perfiles respondidos en más de dos horas, si este límite excede considerablemente, se procede a la invalidación del perfil, puesto que esto puede sugerir que el sujeto ha pensado excesivamente antes de responder, según sus conveniencias personales.

Es importante considerar que existe la probabilidad de que muchos sujetos excedan el tiempo límite puesto que no conocen muchas palabras que conforman los reactivos del inventario, o que no preguntan constantemente acerca del sentido de cada oración. Existen factores culturales que pueden extender el tiempo de aplicación de la prueba, los cuales deben ser considerados por el examinador antes de invalidar el perfil.

Por último, es importante recalcar, que el nivel elevado de respuestas en blanco, también invalida la prueba.

MATERIAL PARA LA ADMINISTRACION Y EVALUACIÓN DEL MMPI, VERSIÓN FOLLETO

Para dicho formato son imprescindibles los siguientes materiales:

- ✓ Cuadernillo – Forma Colectiva
- ✓ Hoja de respuestas
- ✓ Bolígrafo negro con punta gruesa
- ✓ 16 plantillas de corrección caladas
- ✓ Hoja de gráfico y sumatorias
- ✓ Hoja impresa de perfil y gráfico

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA

Antes de establecer la consigna, debe revisarse con mucha cautela el material antes de ser entregado, el mismo no debe tener anotaciones de ningún tipo y todos los ítems deben ser claros y de fácil lectura.

Posteriormente se pueden utilizar las siguientes instrucciones que van a variar considerablemente si se va a aplicar a una persona o a un grupo ya determinado.

Para la aplicación a una sola persona, podría utilizarse la siguiente consigna:

“En el cuadernillo no deberá escribir nada. Todas las respuestas se anotarán en la hoja de registro que está aparte. Usted leerá todos los ítems que parecen escritos en el cuadernillo; cada uno tiene un número y éste es el mismo que aparece en las casillas correspondientes a la hoja de respuestas. A medida que vaya leyendo, piense si lo que dice cada ítem es verdadero o falso para usted. Si considera que es falso, debe marcar en la casilla el lugar correspondiente a la letra ‘V’, si es falso, hará lo mismo a la letra ‘F’. No piense en ‘Sí’ ó ‘No’, porque en su hoja de respuestas no hay lugar para estas posibilidades, lo que puede hacer que se confunda al contestar. Trate de dar respuesta a todos los ítems. En caso de que no entienda alguna palabra o el sentido de alguna frase pida al administrador que se le explique”.¹⁴

¹⁴ BRENLLA, Maria Elena et al, Id.

CONTESTE FRENTE AL MISMO NUMERO QUE PRECEDE A LA FRASE DEL CUADERNILLO

VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
1	51	101	151	201	251	301	351	401	451	501	551
2	52	102	152	202	252	302	352	402	452	502	552
3	53	103	153	203	253	303	353	403	453	503	553
4	54	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554
5	55	105	155	205	255	305	355	405	455	505	555
6	56	106	156	206	256	306	356	406	456	506	556
7	57	107	157	207	257	307	357	407	457	507	557
8	58	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558
9	59	109	159	209	259	309	359	409	459	509	559
10	60	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560
11	61	111	161	211	261	311	361	411	461	511	561
12	62	112	162	212	262	312	362	412	462	512	562
13	63	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563
14	64	114	164	214	264	314	364	414	464	514	564
15	65	115	165	215	265	315	365	415	465	515	565
16	66	116	166	216	266	316	366	416	466	516	566
17	67	117	167	217	267	317	367	417	467	517	
18	68	118	168	218	268	318	368	418	468	518	Puntuaciones directas
19	69	119	169	219	269	319	369	419	469	519	¿.....
20	70	120	170	220	270	320	370	420	470	520	L.....
21	71	121	171	221	271	321	371	421	471	521	F.....
22	72	122	172	222	272	322	372	422	472	522	K.....
23	73	123	173	223	273	323	373	423	473	523	Hs.....
24	74	124	174	224	274	324	374	424	474	524	D.....
25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	Hy.....
	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	Pd.....
26	76	126	176	226	276	326	376	426	476	526	Mf.....
27	77	127	177	227	277	327	377	427	477	527	Pa.....
28	78	128	178	228	278	328	378	428	478	528	Pt.....
29	79	129	179	229	279	329	379	429	479	529	Sc.....
30	80	130	180	230	280	330	380	430	480	530	Ma.....
31	81	131	181	231	281	331	381	431	481	531	Si.....
32	82	132	182	232	282	332	382	432	482	532	Es.....
33	83	133	183	233	283	333	383	433	483	533	Do.....
34	84	134	184	234	284	334	384	434	484	534	Dy.....
35	85	135	185	235	285	335	385	435	485	535	R.....
36	86	136	186	236	286	336	386	436	486	536	Cn.....
37	87	137	187	237	287	337	387	437	487	537	
38	88	138	188	238	288	338	388	438	488	538	
39	89	139	189	239	289	339	389	439	489	539	
40	90	140	190	240	290	340	390	440	490	540	
41	91	141	191	241	291	341	391	441	491	541	
42	92	142	192	242	292	342	392	442	492	542	
43	93	143	193	243	293	343	393	443	493	543	
44	94	144	194	244	294	344	394	444	494	544	
45	95	145	195	245	295	345	395	445	495	545	
46	96	146	196	246	296	346	396	446	496	546	
47	97	147	197	247	297	347	397	447	497	547	
48	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	
49	99	149	199	249	299	349	399	449	499	549	
50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	

Si se está aplicando la prueba a un grupo de dos o más personas, el protocolo de administración de la prueba, podría ser el siguiente: Leer en voz alta las instrucciones que aparecen en la parte superior de la primera hoja del Folleto, para que los examinados entiendan la manera correcta en que deben anotar sus respuestas. Hay que animar a los individuos a que intenten no dejar espacios en blanco, utilizando éste como último recurso al no estar seguro de una respuesta que vaya acorde con su experiencia o forma de pensar.

Es imprescindible que el personal que vaya a aplicar la prueba esté capacitado para responder cualquier interrogante de los examinados hacia la prueba o al significado de cierta palabra o la intención de alguna de las frases.

N

_____ Fecha _____

os académicos _____

		Esc. validación				
Punt. directa	→					
- Fracción K	→	→		→		
Punt. corregida	→	→		→		
		T	?	L	F	K
		100 -	:			
		:				
		:				

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL MMPI

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALAS

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el MMPI consta de 556 frases que el examinado debe clasificar como falsas o verdaderas. “El análisis de las respuestas conduce a un perfil de puntuaciones sobre las diez escalas principales que poseen nombres clínicos y que deben interpretarse psicológicamente: Hipocondría, Depresión, Histeria, Desviación Psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia, Manía¹⁵ e Introversión Social. Existen además cuatro escalas de validez: No sabe (?), Mentira (L), Fiabilidad (F) y Factor corrector (K).¹⁶

a) ESCALAS DE VALIDEZ

ESCALA SINCERIDAD

Llamada también L, puesto que se deriva del vocablo inglés *Lie*¹⁷, esta escala está relacionada con los defectos propios de las personas y la negación de los mismos para intentar mostrar una imagen social más aceptable.

La puntuación elevada o no en esta escala de 15 ítems, parece estar relacionada con el nivel cultural y de formación de los examinados, puesto que puntuaciones bajas se observan en sujetos con niveles educacionales altos, mientras que personas con menos formación tienden a obtener puntuaciones elevadas. Es importante mencionar que una puntuación elevada no invalida la prueba, pero sí puede ser un indicador de que su valor real es posiblemente mayor al obtenido, o en otro caso puede ser resultado de un determinado tipo o rasgo de personalidad.

Las puntuaciones elevadas (T 70 o mayor), pueden relacionarse con:

- Tratar de mostrar una imagen falsa y /o aceptable de uno mismo.
- Personas convencionales o conformistas

¹⁵ Hipomanía

¹⁶ NUÑEZ DE ARCO, Pg 136.

¹⁷ Vb Mentir o Mentiras

- Falta de originalidad en el pensamiento, excesiva moralidad y rigidez.
- Sobreestimación y confusión
- Falta de capacidad a la hora de reconocer problemas personales y su solución.
- Falto conocimiento de motivaciones
- Personas con baja tolerancia a la frustración, estrés y / o presiones circunstanciales.
- En casos raros puede ser a consecuencia de un problema clínico de naturaleza orgánica.

Puntuaciones bajas (T49 o menor) corresponden a:

- Personas sinceras con elevada autocrítica y confianza en sí mismas para poder admitir pequeños defectos propios.
- Capacidad de liderazgo, espontaneidad, independencia y autonomía.
- Elevado potencial al transmitir ideas
- Sus semejantes lo describen como cínico y sarcástico, no le importa el *Qué dirán*.

ESCALA DE VALIDEZ (F)

Del inglés *Frequency*¹⁸, esta escala compuesta de 64 ítems no es una escala de personalidad, sino más bien asegura el valor que se le debe dar al conjunto de respuestas dadas que componen el MMPI. Es una escala multidimensional, puesto que abarca características tan disímiles entre sí como la raza, actitudes para con el medio, conductas antisociales, experiencias extrañas, religión, trastornos del pensamiento o de sueño.

Las respuestas elevadas pueden invalidar la prueba, pero antes se debe realizar varias consideraciones en torno a dicha puntuación.

Puntuaciones altas (T 100 o mayor) sugieren:

¹⁸ Frecuencia

- Respuestas ejecutadas al azar o por incapacidad del sujeto para comprender lo que está leyendo. Puede haber respondido *Verdadero* ó *Falso* a todos los reactivos.
- La hoja de respuestas está mal llenada o la prueba mal corregida.¹⁹
- Simulación de enfermedad mental, o exageración de la misma para obtener ayuda.
- Puede tratarse de un paciente psiquiátrico seriamente perturbado
- Inconformismo o resignación ante creencias y / o costumbres políticas, sociales o religiosas.

Como se observa, las puntuaciones elevadas en esta escala tienen un carácter interpretativo multidimensional. Puede tratarse de un paciente psicótico²⁰ o simplemente no quiere colaborar al invalidar el perfil.

Puntuaciones T en un rango de 80 a 99 sugieren:

- Haber respondido todos los reactivos *Falso*
- Simulación o exageración de síntomas
- Resistencia a la prueba
- Falta de cooperación
- Psicosis

Puntuaciones T de 65 a 79:

- Rigidez en sus convicciones morales, sociales o políticas
- Trastorno neurótico o psicótico
- Una vez descartado un trastorno psiquiátrico, puede tratarse de una persona: Oportunista, Depresiva, Impaciente, Insatisfecha, Inestable, o curiosa.

¹⁹ Es importante que el examinador realice un conteo eficiente y esté seguro de la exactitud de las plantillas, para evitar perfiles incorrectos.

²⁰ Debe establecerse relación con las escalas de Paranoia y Esquizofrenia.

Puntajes T de 50 a 64:

- El sujeto respondió los reactivos hacia un área de conflicto particular
- Posiblemente se trate de una persona neurótica
- Adaptabilidad y buen funcionamiento en otros aspectos de su vida, divergidos a las áreas de conflicto. (Enfermedades, etc.)

Puntuaciones bajas (T 50 o menor) sugieren:

- La mayoría de los sujetos normales y libres de tensión obtienen puntuaciones bajas en esta escala. Respuestas razonables
- Conformidad social
- Conformismo
- El sujeto puede haber fingido un buen perfil para proyectar una imagen aceptable de sí mismo.
- Negación de dificultades personales
- Se descarta psicopatología severa

ESCALA FACTOR CORRECTOR (K)

Esta escala compuesta de 30 reactivos fue diseñada como una variable de corrección para incrementar la autoridad de algunas escalas clínicas del MMPI, para medir las actitudes del examinado ante la prueba. Dicha escala abarca áreas en las que el sujeto puede generar cierta resistencia, como ser: Problemas familiares, bajo nivel de autoconfianza, agresividad, preocupación.

Puntuaciones altas (T 71 o más), sugieren:

- Posible negación de problemas personales²¹
- Haber respondido *Falso* a gran parte de los reactivos
- Pretender dar una imagen personal de control y eficacia.

²¹ Se debe considerar la probabilidad de un trastorno mental, puesto que la persona puede tener poca o ninguna conciencia de sus conflictos.

- Timidez, indecisión, inhibición
- Falta de autoconocimiento y autoentendimiento
- Intolerancia a convicciones extrañas o poco convencionales
- Baja probabilidad de conductas antisociales

Puntuaciones promedio (T 41 a 70), señalan:

- Adaptación, sociabilidad, capacidad intelectual alta
- Independencia, autoconfianza
- Alto nivel de comunicación con el medio
- Comprensión y solución de problemas en forma independiente y razonable
- Ingenio y versatilidad.
- Elevado control en sus relaciones interpersonales
- Pensamiento claro
- Pocos síntomas de trastorno emocional

Puntuaciones bajas (T 40 o menos) se relacionan con:

- El examinado respondió *Verdadero* a la mayor cantidad de reactivos
- Desorganización emocional, debilidad yoica, ingenuidad, autocrítica
- Pretender proyectar una imagen inaceptable de su persona.
- Timidez, inhibición, incapacidad de relacionarse con los demás
- Sincero y torpe en sus relaciones, cínico o incrédulo
- Conformista
- Tendencia a la autocrítica
- Exageración de sus conflictos como grito de ayuda
- Abulia
- Desconfianza, suspicacia de los demás
- Dificultad a la hora de enfrentar los problemas y / o darles solución
- Confusión orgánica o psicótica
- Niveles bajos de autoconocimiento y autocomprensión

INVALIDEZ DEL PERFIL

Muchos autores coinciden en invalidar el perfil cuando el examinado ha omitido al menos 30 reactivos. Sin embargo otros afirman que ésta es una posición muy conservadora puesto que esto significaría la invalidación de muchos perfiles. El tiempo de ejecución de la prueba también es un factor importante a la hora de invalidar pruebas, éste debe estar dentro de los parámetros normales, eso sí se debe tomar en cuenta el grado de instrucción del examinado, puesto que es obvio que una persona que tenga problemas de lectura tarde mucho más tiempo que otro que no los tenga. En nuestro país hay que considerar otros factores, el factor cultural es muy importante puesto que la mayoría de la población habla quechua (u otro dialecto) y español, lo cual podría significar un incremento considerable del tiempo de ejecución de la prueba.

SERIE DE RESPUESTAS DESVIADAS

Muchas personas con ciertos problemas de lectura y comprensión tienden a confundir o malinterpretar las instrucciones, también es posible que el sujeto tenga cierta resistencia a la prueba; por eso si la prueba es aplicada individualmente, es deber del examinador el percatarse de los posibles pormenores.

RESPUESTAS AZAROSAS

Son las respuestas que como su nombre indica las realiza al azar. Muchas personas responden automáticamente una respuesta *verdadera* y la siguiente *falsa*; o utilizar bloques de respuestas falsas y / o verdaderas. Si este es el caso, se invalida automáticamente el perfil. El gráfico expuesto a continuación es el de un sujeto cuyo perfil fue validado porque la mayoría de los reactivos fueron respondidos al azar.

RESPUESTAS TODO CIERTO Ó TODO FALSO

Cuando el examinado ha respondido todo cierto o falso es probable que no entendió claramente las instrucciones o tiene una actividad negativa hacia el proceso evaluativo. Si hubiese respondido todo cierto las puntuaciones son muy elevadas y

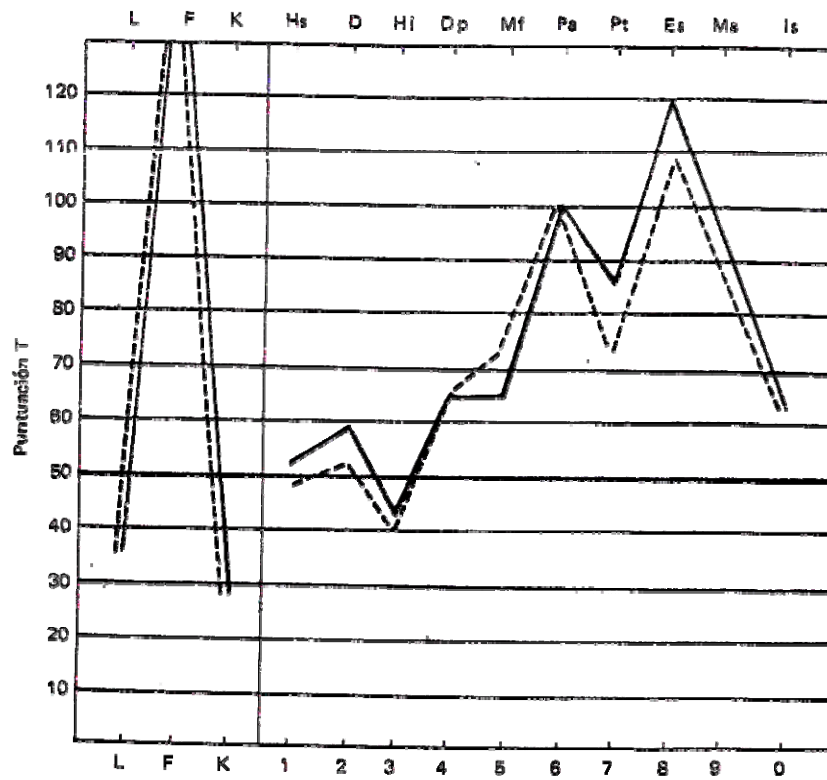
sobresalientes en la hoja del perfil. (ver gráfico) mientras que las *todo falso* muestran una V pequeña. (ver gráfico)

FINGIR MAL

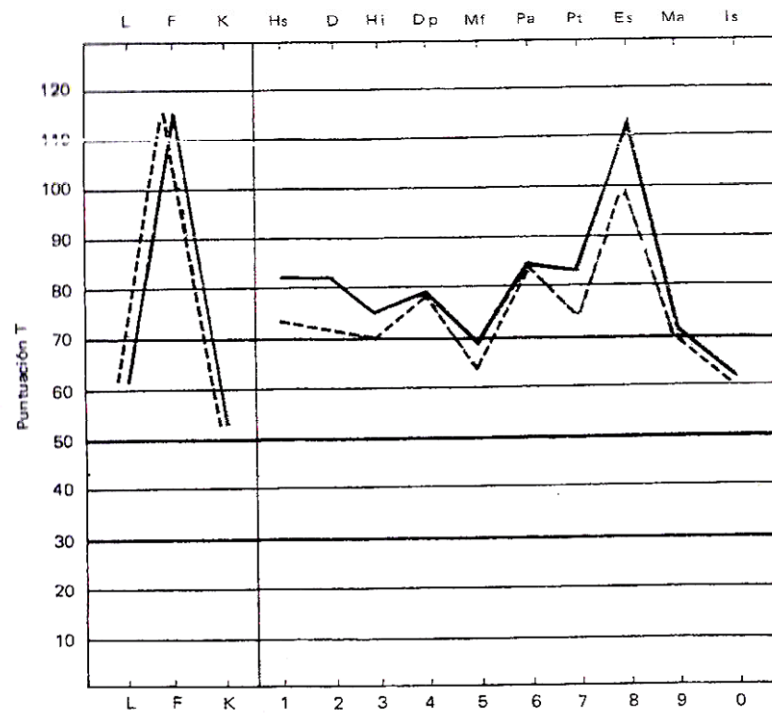
Muchas personas fingen o exageran sus síntomas pretendiendo dar una imagen negativa de sí mismo para lograr ciertos fines. Por ejemplo una persona acusada por asesinato sabe muy bien que podría alegar una enfermedad mental para ser considerada inimputable (ver gráfico 4), entonces trata de crear la impresión de una psicopatología grave. Pero ¿Cómo se puede diferenciar el perfil de una persona que ha fingido mal con el otro de un sujeto con verdadera psicopatología? Para ello se debe considerar lo siguiente: La escala F es generalmente más alta que 100 y las escalas clínicas son más elevadas que las del perfil de una persona con patología. (exageración)

FINGIR BIEN

La persona está muy consciente de su problema, busca ayuda profesional, pero a la hora de responder a la prueba 'finge bien' con el propósito de que el examinador tenga una imagen diferente de él. (ver gráfico)



Perfiles con corrección K indicativos de una serie de respuestas todo cierto para hombres (—) y mujeres (---).



Perfiles con corrección K indicativos de una serie de respuestas azarosas para hombres (—) y mujeres (---).

b) ESCALAS CLÍNICAS

“Las escalas clínicas permiten evaluar, en un sujeto, diferentes dimensiones de la personalidad y obtener información acerca de probable patología”²²

A continuación se exponen las escalas clínicas a detalle, es importante que el examinador las estudie bien y en el momento de elaborar el perfil tenga la habilidad de establecer relación unas con otras.²³

Apellidos y nombre _____																				
Profesión _____										Estado civil _____					Estudio _____					
Esc. validación					Escalas básicas										Esc. adicionales					
T	?	L	F	K	Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si	Es	Dy	Do	Rel	Cn	T
100-					05K			04K			1K	1K	0,2K							-100
⋮																				⋮

ESCALA 1 HIPOCONDRIASIS Ó HIPOCONDRIA (HS)

Esta escala evalúa la ansiedad exagerada ante las propias funciones corporales. Esta tendencia puede ser resultado de un mecanismo de defensa o de protesta hacia el medio puesto que la soledad u otros sentimientos inaceptables se transforman en autoreproche y continuas quejas por enfermedades somáticas inexistentes, a pesar de existir resultados médicos que evidencien la ausencia de enfermedad. Síndrome psíquico constituido por la preocupación excesiva y angustiosa, a menudo infundada, hacia la propia salud. En la base de la hipocondría

²² BRÉENLA, Pg 46

²³ Ver combinación de dos escalas

suele existir una disposición personal que induce al sujeto a la autoobservación y la interpretación. Son observados frecuentemente trastornos reales, circulatorios, endocrinos, digestivos, matizados por el sujeto o condicionados por el propio sujeto.

Las puntuaciones elevadas en esta escala sugieren (alrededor de T 60):

- Baja comprensión de problemas psicológicos personales
- Preocupación excesiva por la salud
- Egoísmo, narcisismo, inmadurez para enfrentar problemas propios
- Puede significar expresión indirecta de agresividad
- No presenta ansiedad manifiesta
- Pesimismo, negativismo, infelicidad, insatisfacción
- Dificultad de expresarse oralmente
- Sienten que están verdaderamente enfermos y buscan ayuda médica
- Si presentan un problema médico, es probable que sea una manifestación psicósomática
- Manifestación de quejas constantes por su enfermedad, gustan de hacer sufrir a los demás.
- Puede haber fracaso en la psicoterapia, críticas al psicoterapeuta, falta de *insight*, resistencia al diagnóstico e interpretación psicológica

Puntuaciones bajas representan lo siguiente:

- No presentan quejas o preocupaciones somáticas, pero pueden llegar descuidar su salud
- Optimismo, satisfacción
- Personas alertas, perceptivas, seguramente inteligentes, ambiciosas
- Buen desempeño en la vida cotidiana
- Buen pronóstico en psicoterapia, capacidad de *insight*
- Sujetos bien adaptados

ESCALA 2 DEPRESIÓN (D)

La depresión es un estado emocional que se caracteriza por pensamientos tristes o pesimistas, sentimientos de inutilidad y falta de confianza en uno mismo. Desorden emocional caracterizado por una respuesta inadaptada a los estímulos, de tal manera que quien la padece se muestra apático, sin ánimo y con poca iniciativa; generando alteraciones en el sueño y la alimentación. Compuesta por 60 reactivos esta escala evalúa la depresión sintomática enfocada hacia considerables aspectos de la depresión desde el abandono hasta el rechazo de impulsos.

Las puntuaciones elevadas(puntuaciones T más de 80) indican que el examinado presenta:

- Sentimientos de culpa y autoacusatorios, autodesprecio, infelicidad, inutilidad, tristeza, excesiva preocupación
- Pesimismo, negativismo, falta de interés hacia el futuro
- Sentimientos de fracaso en los estudios o en el ámbito laboral
- Continuas quejas de debilidad, padecimiento físico, cansancio
- Depresión oculta manifestada por la llamada “depresión sonriente”
- Falta de confianza en sí mismo, se da por vencido rápidamente, evita enfrentamientos y solución de problemas, dificultad para tomar decisiones, no es agresivo
- Tendencia ala soledad y aislamiento, retraimiento, se niega a conversar de su problemas
- Llanto, irritabilidad, nerviosismo, agitación
- Distanciamiento de actividades que gustaba realizar antes
- Convencionalismo y cautela
- Pueden responder efectivamente a la psicoterapia puesto que sus niveles de demanda son elevados

Las puntuaciones bajas (T 54) revelan:

- Proyección optimista de la vida, autoconfianza, estabilidad emocional, bajos niveles de depresión y sentimientos de culpa
- Energía elevada para afrontar los problemas y encontrarles solución
- Relajación, comodidad, felicidad, energía y competitividad
- Capacidad de liderazgo, ingenio, creatividad. Suelen tener problemas con personas con autoridad sobre ellos (jefes, policía, etc)
- Bajo control de impulsos
- Comodidad y adaptación ante relaciones sociales
- La gente de su entorno los consideran personas alegres, inteligentes, interesantes, con buen sentido del humor. Generalmente dan una buena primera impresión
- Suelen ser exhibicionistas y narcisitas, por lo que pueden despertar en las otras personas sentimientos hostiles y de resentimiento

ESCALA 3 HISTERIA (Hy)

La Histeria es un trastorno de tipo psicógeno perteneciente al grupo de las neurosis, fue el primer objeto de estudio de Freud en 1885, de acuerdo con el mismo, en el enfermo histérico, se admite un anormal desarrollo psicosexual, con fijación en la etapa edípica.

Hoy en día, el Manual para el diagnóstico de enfermedades de la APA, considera los siguientes síntomas relacionados con la llamada *Histeria de Conversión*: Presencia de síntomas que afectan el buen desenvolvimiento de las funciones motoras o sensoriales, sugiriendo trastorno neurológico u otra enfermedad médica (Criterio A). Los factores de orden psicológico están asociados al síntoma (Criterio B). Los síntomas no son simulados, ni intencionados, a diferencia de lo que sucede en el trastorno facticio o en la simulación (Criterio C).

Conformada por 60 reactivos, la escala 3 fue elaborada con el propósito de diferenciar los síntomas ante situaciones tensas entre las personas con histeria de conversión de las personas normales.

Las puntuaciones elevadas en esta escala (T 80 o más) manifiestan:

- Inseguridad, inmadurez, infantilismo. Pueden ser egocéntricos y narcisistas
- Desarrollan enfermedades para evadir responsabilidades, dichas enfermedades aparecen y desaparecen rápidamente. Quejas continuas de dolores de cabeza, espalda, estómago y corazón
- Tendencia a la preocupación
- Sus síntomas pueden ser aliviados por la *conversión de fe*.
- Utilizan técnicas manipuladoras, tortuosas para obtener atención y simpatía
- No expresan abiertamente sentimientos hostiles y de resentimiento hacia los demás
- Generalmente no manifiestan delirios ni alucinaciones
- Se involucran emocionalmente, son amistosos y conversadores. Da más de sí de acuerdo a sus intereses personales
- Pueden aceptar consejos y sugerencias
- Su relaciones son superficiales e inmaduras, siente constantemente rechazo por su grupo social y suele mantenerlo con manipulaciones de todo tipo
- Manifiesta preocupación ante el fracaso escolar o laboral aunque suelen ser muy poco trabajadores y con pocas aspiraciones
- Pueden tener “acting out” sexual aunque no lo sientan verdaderamente
- No manifiesta síntomas depresivos
- Siente infelicidad y fracaso en su matrimonio
- Le cuesta comprender los orígenes de su propio comportamiento

- Suele tener problemas para con la figura paternal, manifiesta haber tenido rechazo por parte de su padre
- Al principio muestran interés en la psicoterapia aunque tienen dificultades de *insight* y se resisten a las interpretaciones psicológicas.

Puntuaciones bajas en esta escala indican que el examinado es:

- Poco interesado en las relaciones sociales, conformista, con tendencia al aislamiento
- Poco preocupado por su salud, no manifiesta síntomas somáticos
- Frío, distante, realista, poco arriesgado
- Desconfiado y suspicaz
- Satisfecho ante una forma de vida monótona
- Obstinado, poco amistoso y evita situaciones donde él sea el líder
- Conformista, con pocas metas

ESCALA 4 DESVIACIÓN PSICOPÁTICA (Pd)

El DSM IV en relación a la desviación psicopática manifiesta: “La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta.” ²⁴

Este trastorno es de iniciación temprana y los criterios de diagnóstico son los siguientes: falta de remordimiento por sus actos delictivos, búsqueda de satisfacción a largo plazo, negligencia laboral o escolar, indiferencia hacia los sentimientos ajenos, narcisismo, predisposición a la adicción de estupefacientes u otras drogas, tendencia al suicidio, decisiones importantes tomadas al azar, etc. Por tanto esta escala está compuesta de 50 reactivos relacionados con características de personas antisociales o que tienen constantes problemas legales aunque estos no sean muy severos, tales como robar, promiscuidad sexual, mentir o dependencia a

sustancias como el alcohol o las drogas, insatisfacción familiar, problemas con la autoridad, etc.

Las puntuaciones altas en la escala 4 (T 70 o más) sugieren:

- Personas trabajadoras y ambiciosas sin manifestar comportamientos antisociales²⁵
- Rebeldía, rechazo a las normas sociales y legales
- Problemas familiares y legales, inadaptación social y sexual
- Impulsividad manifiesta, agresividad, sarcasmo, rencor, poco sentimiento de culpa aunque la manifiesta cuando está en problemas
- Personas con tendencias delictivas como mentir, robar, estafar, abuso de alcohol u otras drogas, rebeldía hacia la autoridad
- Personas narcisistas, exhibicionistas, egocéntricas y egoístas
- Impaciencia, impulsividad y poca tolerancia a la frustración
- *Acting out*
- Sujetos que delegan las responsabilidades de sus actos a otras personas (familia, amigos)
- Grandes expectativas pero cambiantes
- Problemas de pareja
- Escasa sensibilidad hacia los sentimientos ajenos
- Antecedentes escolares y laborales deficientes que revelan conflicto con los compañeros
- Inteligencia, seguridad, intelectualización

²⁴ DSM IV

²⁵Importante tomar en cuenta

- Individuos amistosos, amables, conversadores, aventureros
- No tiene síntomas psicóticos
- Incapacidad de establecer vínculos profundos o íntimos con los demás
- Respuestas emocionales superficiales
- Pronóstico terapéutico poco favorable, aunque acepta ir a terapia para evitarse problemas legales

Puntuaciones bajas en Pd indican:

- Individuos conformistas, reservados, pasivos, moralistas y con bajas expectativas
- Sumisión ante reglas y normas sociales o legales
- Preocupación por lo que digan o piensen los demás
- Sujetos no muy competitivos
- Sinceridad y confianza hacia los demás
- Aceptan consejos y sugerencias
- Falta de creatividad y espontaneidad
- Insatisfacción personal y autocrítica constante
- Rigidez en sus convicciones políticas, morales o religiosas
- Tendencia a depender de la psicoterapia

ESCALA 5 MASCULINIDAD – FEMINIDAD (Mf)

Esta escala fue desarrollada para diferenciar la población heterosexual de la homosexual. “Los ítems de se refieren a las afirmaciones, trabajos, relaciones sociales y familiares, religión, sexo, sensibilidad personal y miedos”²⁶

Puntuaciones elevadas en varones sugieren:

- Personas con una amplia educación y cultura. Intereses hacia el arte, la estética y la belleza
- Sujetos autocontrolados, amables, tolerantes, pasivos, dependientes en sus relaciones, con bajos niveles de agresividad; prefieren siempre hacer uso del diálogo para evitar enfrentamientos.
- Buen control de impulsos, es muy rara la presencia del *acting out*
- Poco violentos, tranquilos, dóciles y sensibles
- Probabilidad de comportamientos visiblemente afeminados (amanerados). Falta de interés en cometer conductas varoniles estereotipadas
- Gustan de participar en las labores de la casa y el cuidado de niños
- Posibles dudas de identificación sexual
- Homosexualidad manifiesta o reprimida
- Presencia de lógica y metas claras. Curiosidad
- Personas ambiciosas, competitivas, constantes en sus metas, creativas, prefieren solucionar sus problemas por sí solos

Puntuaciones bajas para hombres señalan:

- Sujetos toscos, groseros, violentos, aventureros y prácticos
- Se consideran a sí mismo como personas masculinas y varoniles
- Sus intereses son exclusivamente “para hombres” (fútbol, películas violentas, viernes en la noche con amigos, situaciones donde demuestre su capacidad y

²⁶ TEA MMPI

fuerza física. etc). Existe la probabilidad de que esté sublimando sus temores acerca de su sexualidad por medio de estas conductas.

- Dispuestos al matrimonio
- Poca originalidad, escasos intereses
- Personas con inteligencia, cultura y educación no muy cultivadas
- Posibilidad de lenguaje vulgar y ordinario
- Jovialidad, felicidad
- Dificultad para expresar sentimientos y emociones (“Los hombres no lloran”, por lo que podría perjudicar en la psicoterapia al no tener capacidad de *insight*)

Puntuaciones altas en mujeres sugieren:

- Equilibrio, estabilidad, seguridad y vigor corporal
- Personas que se revelan ante los roles femeninos estereotipados por medio de comportamientos masculinos
- Los demás las consideran poco amigables, torpes y varoniles
- Agresividad y dominancia, poca dependencia
- Autoconfianza

Puntajes bajos en mujeres manifiestan:

- Sensibilidad, sumisión, dependencia, pasividad, modestia
- Buen control de impulsos
- Personas con visibles conductas femeninas, agradables, delicadas, perceptivas, sin prejuicios, responsables, quejumbrosas
- Probabilidad de conflictos en su sexualidad, conflictos que son disfrazados por conductas estereotipadas femeniles

- Los demás las consideran inteligentes, firmes y respetadas aunque ellas se sientan mal consigo mismas
- Capacidad *insight* , favorable en la psicoterapia

ESCALA 6 PARANOIA (Pa)

La paranoia es un trastorno mental que se caracteriza por la aparición de delirios e ideas fijas. Suele acompañarse de manía persecutoria y/o manía de grandeza. Tiene distintos grados, por lo que puede hablarse de trastornos paranoides o de psicosis paranoica. “La característica esencial del trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de éstos son interpretadas como maliciosas.” ²⁷

Delirio interpretativo que evoluciona de forma progresiva, con una lógica aparentemente perfecta y sin deterioro intelectual. La paranoia es raro que se establezca de forma pura, por eso es más favorable hablar de un Trastorno de Paranoide de la Personalidad, cuyos rasgos esenciales son una exagerada susceptibilidad, una hipervaloración del yo, desconfianza y una construcción mental peculiar.

Por consiguiente la escala 6 compuesta por 60 ítems fue originalmente elaborada con el propósito de identificar a pacientes con síntomas paranoides. Es importante mencionar que si bien esta escala identifica a personas con estas características, son las mismas que a veces advierten al examinado sobre los propósitos del inventario y éste se muestra reacio a contestar los reactivos sinceramente, llegando a obtener puntuaciones bajas gracias a su suspicacia.

Puntuaciones con elevaciones extremas (T 75 ó más) sugieren:

- Sujetos con síntomas psicóticos
- Presencia de pensamientos perturbados. Delirios de grandeza e ideas de referencia

²⁷ DSM IV Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales. American Association de Washington. Ed. Masson. Barcelona 1995

- *Proyección* como mecanismo de defensa
- Hostilidad
- Rencor
- Usualmente son diagnosticados como esquizofrénicos o con desorden paranoide
- Se sugiere internación o farmacoterapia

Puntuaciones moderadas (T 65, 75) en la escala 6 manifiestan:

- Tendencias paranoides
- Sensibilidad
- Personas interesadas en la opinión ajena
- Sujetos quejumbrosos, celosos, desconfiados, susceptibles
- Hostilidad hacia sus familiares y el medio
- Moralidad, rigidez en sus convicciones, racionalidad
- Las mujeres manifiestan tristeza, estados depresivos
- Poca capacidad de establecer *rapport* con el terapeuta
- Poca capacidad de *insight* , tienden a racionalizar y / o negar sus conflictos emocionales

Puntuaciones con elevación media (T 55 a 65) indican:

- Personas que se sienten enojadas y resentidas. Tienen a desconfiar de las motivaciones de los demás
- Notorio interés por las opiniones ajenas
- Sujetos enérgicos, trabajadores, creatividad, inteligentes, colaboradores
- Falta de autoconfianza

- Nerviosismo y preocupación
- En terapia, tiene buena capacidad de *insight*

Puntajes moderadamente bajos en pacientes no psiquiátricos (T 35 a 45) manifiestan:

- Alegría, equilibrio
- Sujetos ordenados, razonables, maduros en sus relaciones, prudentes
- Lealtad, confianza
- Reservado, convencional y con autocontrol
- Interesado en actividades sociales
- Adaptación a situaciones cotidianas
- Los demás las describen como personas ordenadas, sensatas, organizadas y cautelosas

Puntajes moderadamente bajos en pacientes clínicos (T 35, 45) corresponden a personas:

- Que son descritas por los demás como evasivas, reservadas, desconfiadas y obstinadas
- Con falta de intereses
- Insatisfechas, sensibles, egocéntricas, con convicciones rígidas, poco exitosas
- Torpes, descorteses, rudas
- Susceptibles
- Poca capacidad de *insight*

Puntuaciones extremadamente bajos (T 35 o menos) sugieren personas que:

- Tienen trastorno de tipo paranoide

- Pueden manifestar delirios, ideas de referencia
- Tímidas, rígidas, introvertidas
- Son desconfiadas, evasivas, recelosas

ESCALA 7 PSICASTENIA (Pt)

Esta escala está desarrollada para identificar fobias y conductas obsesivas compulsivas. Las fobia según el DSM IV es: "... un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones claramente discernibles y circunscritos". Las fobias agrupan todo tipo de miedos o temores sin causa aparente, ilógicos de cualquier cosa o situación, así mismo reacciones con mucha carga emocional ante dichos estímulos.

Por su parte el trastorno obsesivo compulsivo es también una manifestación de una saturada carga ansiógena, puesto que está acompañada de obsesiones y compulsiones que perjudican el desarrollo de una vida normal para el sujeto (laboral, familiar, social). Por tanto esta escala de 48 reactivos evalúa lo que antes se denominaba Psicastenia²⁸, cubriendo múltiples síntomas y conductas ligados siempre a factores ansiógenos e irracionales.

Puntuaciones elevadas (T 70 o más) indican presencia de:

- Sentimientos de culpa, ansiedad, rituales, miedos irracionales, rigidez en convicciones religiosas o morales, pensamientos obsesivos, comportamientos compulsivos.
- Labilidad de intereses
- Intelectualización
- Preocupación excesiva, nerviosismo, temor, agitación, ansiedad, angustia
- Falta de concentración, dificultad a la hora de tomar decisiones. Rumiación permanente de problemas y sus posibles soluciones
- Responsabilidad, rigidez, perseverancia, confiabilidad

²⁸ Término poco utilizado en la actualidad

- Personas prolijas, detallistas, perfeccionistas, autoexigentes, manifiestan ansiedad al no cumplir su metas o rituales
- Reacciones exageradas ante situaciones estresantes
- Autodesprecio, autocrítica
- Dificultad en relaciones sociales, tendencia al aislamiento, poca o nula expresión de ideas o sentimientos, preocupación e importancia por las opiniones ajenas
- Posible presencia de depresión ²⁹
- Sensibilidad, generosidad, dependencia, inmadurez
- Padecimiento del corazón, gastrointestinal, urinario o agotamiento físico (debilidad, insomnio, pesadillas, fatiga)
- Pueden asistir a terapia motivados por sus problemas físicos
- Cierta capacidad de *insigth*. Racionalización, resistencia a las interpretaciones psicológicas, hostilidad hacia el terapeuta
- La terapia tiene un ritmo lento pero efectivo

Los puntajes bajos en la escala 7 indican:

- Sujetos equilibrados, adaptados, capaces, eficientes, sin preocupaciones innecesarias
- Ausencia de temores desadaptativos
- Valoran la posición social, económica y el reconocimiento
- Personas sumisas, amistosas, tienden a sobrevalorar los propios éxitos
- Autoconfianza, metas e intereses variados

ESCALA 8 ESQUIZOFRENIA (Sc)

²⁹ En este caso debe valorarse la posibilidad de suicidio

La esquizofrenia es una enfermedad mental caracterizada por la escisión de la personalidad y por una ruptura de los mecanismos psíquicos normales, lo que provoca una conducta incomprensible y una pérdida del contacto con la realidad. Término utilizado por primera vez por Bleuler en 1908, la cual es una profunda enfermedad mental caracterizada por alteraciones de todas las funciones de la personalidad, más notablemente del pensamiento, la afectividad y la conducta. El pensamiento está alterado tanto en su curso (interpretación, robo, etc.) como en su contenido (alucinaciones, ideas delirantes, etc.) La afectividad también es afectada puesto que, se observa una profunda inestabilidad e inadecuación emocional, reducción (tendencia autista), ambivalencia, etc. En la conducta, tendencia al aislamiento, extravagancia, actuaciones impredecibles, etc.

Por lo general, los síntomas de la esquizofrenia se dividen en tres categorías:

1. Los *positivos* incluyen delirios y alucinaciones que ocurren cuando el paciente ha perdido el contacto con la realidad. Los *delirios* hacen que los pacientes creen que otras personas les están leyendo la mente o están conspirando en su contra; también creen que alguien los está vigilando y amenazando en secreto o que ellos mismos pueden controlar la mente de los demás. Las *alucinaciones* hacen que la persona oiga o vea cosas que no están presentes o no existen.
2. Los *síntomas desorganizados* que incluyen ideas y habla confusas y comportamiento que no tiene sentido alguno para los demás.
3. Los *síntomas negativos* incluyen embotamiento emocional o falta de expresión, incapacidad de comenzar y terminar actividades, habla breve y aparentemente incoherente y falta de interés y placer en la vida (abulia, alogia, anhedonia.)

Considerando la complejidad de los síntomas característicos de la esquizofrenia la escala 8 compuesta por 78 reactivos, fue desarrollada en base a la consideración diagnóstica de pacientes esquizofrénicos, pero es importante mencionar que muchos de los síntomas antes mencionados no siempre pueden ser de origen orgánico, puesto que también pueden ser generados el abuso de drogas (*Delirium*

Tremens) o por algunas enfermedades como el Síndrome Comicial o llamado también Epilepsia.

Puntuaciones elevadas (T 80 a 90) suelen a obtener personas que:

- También tienen puntuaciones elevadas en otras escalas
- Pueden ya estar diagnosticadas con un trastorno psicótico
- Manifiestan confusión, desorganización y desorientación. Sus objetivos son vagos, indeterminados, inalcanzables o exagerados
- Tienen una variedad de afanes y ambiciones
- Evaden la realidad, refugiándose en sus sueños y fantasías, evitando de esta manera afrontar situaciones nuevas, conflictivas y /o de contacto personal. Conflictos para diferenciar la fantasía de la realidad
- Pueden tener delirios y alucinaciones
- Tienen poca tolerancia a la frustración, prefieren confinarse en sus fantasías
- En algunos casos pueden responder a los conflictos de manera creativa, imaginativa y fantasiosa.
- Tienen escasa capacidad de juicio
- Experimentan ansiedad generalizada y una aguda agitación psicológica
- Se quejan de dolores ligeros e indefinidos
- Tienen sentimientos de inferioridad, dudan de sí mismas, se sienten insuficientes, decepcionadas, insatisfechas; y pueden manifestar conflictos sexuales
- Pueden manifestar haber tenido experiencias peculiares, alucinaciones, pensamientos inusuales
- Manifiestan poca actividad en relaciones sociales con tendencias esquizoides
- Son apáticas, impulsivas, manifiestan hostilidad, desordenadas, resentidas, incomprendidas, inadaptadas, excéntricas, nerviosas, prolijas
- Algunas veces son descritas como tranquilas, amigables, generosas y románticas
- Estén exagerando sus síntomas manifestando implícitamente un llamado de auxilio

- Si son adolescentes pueden estar manifestando rebeldía hacia un medio percibido como perjudicial
- Pronóstico en la psicoterapia negativo, es mejor considerar ayuda psiquiátrica y farmacoterapia

Puntuaciones bajas indican:

- Bondad, sensibilidad, dependencia, responsabilidad
- Pensamiento concreto y práctico
- Resistencia a situaciones competitivas
- Preocupación por el estatus
- Personas equilibradas, poco imaginativas, convencionales, responsables, conservadoras, sumisas, confiables

ESCALA 9 HIPOMANIA (Ma)

Esta escala consta de 46 reactivos que evalúan estados hipomaniacos moderados, puesto que a juzgar por las características propias de la Hipomanía grave, resultaría imposible llegar a aplicar la prueba. En otras palabras mide características de personalidad ligadas a la hiperproductividad del pensamiento y la conducta, puesto que los reactivos están relacionados con ideas de grandeza, actividad elevada, relaciones sociales y familiares, etc.

Personas con puntuaciones altas (T 80 o más) manifiestan:

- Megalomanía, incapacidad de reconocer limitaciones propias, alucinaciones, delirio de grandeza, labilidad emocional, fuga de ideas
- Excitación, hiperactividad, irritabilidad, hostilidad injustificada e irracional, agitación, rapidez psicomotora, poca tolerancia a la frustración
- Estado de ánimo elevado
- Insatisfacción
- Periodos depresivos
- Tendencia al aburrimiento ante situaciones consuetudinarias

- Inestabilidad, preocupación exagerada
- Poca capacidad de control de impulsos
- Gusto por las relaciones sociales
- Rebelión ante roles femeninos tradicionales (si es mujer)
- Relaciones superficiales, son descritos como personas sociables, amigueras, manipuladoras y de poca confianza
- Presencia de varios intereses y metas, llagando a cumplir pocos o ninguno
- Optimismo idealizado y exagerado
- Intelectualización
- Creatividad, ingenio
- Personas normales (no presentan cuadros hipomaníacos) pero activas y enérgicas
- Pronóstico de terapia no favorable puesto que tienden a resistirse a las interpretaciones psicológicas, actitud hostil hacia el terapeuta y falta de asistencia a las sesiones

Examinados con puntajes bajos sugieren:

- Apatía
- Exagerado control de impulsos
- Depresión
- Convencionalismo
- Sujetos hogareños con ganas a casarse (si el examinado es hombre)
- Humildad, modestia
- Indiferencia y poco afán antes cosas o situaciones que se presentan
- Falta de energía, poca actividad (características propias en personas seniles, enfermos hospitalizados, medicados con tranquilizantes) En el caso de los pacientes psiquiátricos hospitalizados se establece un buen pronóstico de la terapia

ESCALA 10 INTROVERSIÓN SOCIAL (Si)

Mal llamada escala clínica, actualmente está considerada como una. La presente escala citada por otros autores como *Escala 0* evalúa lo que se conoce como *Introversión* que es una característica de la personalidad o de la comportamiento de una persona mediante la cual tiende a cerrarse en sí mismo, evitando el contacto con los demás. Construida en base a 69 reactivos los cuales unos se refieren a la participación social, mientras que otros enfocan problemas neuróticos y baja autoestima.

Puntuaciones altas en la escala Si sugieren:

- Sujetos introvertidos con poco o nulo interés en relaciones de tipos social que manifiestan ansiedad y perturbación ante reuniones con mucha gente desconocida
- Gusto por participar en grupos pequeños o simplemente sin compañía
- Incomodidad ante el sexo opuesto, por tanto pueden manifestar problemas de pareja}
- Depresión
- Sumisión y obediencia
- Dificultad para tomar decisiones
- Apatía, timidez, reflexión, inseguridad, irritabilidad, ansiedad, malhumor
- Disfrutan de sus logros personales
- Desconfianza, inseguridad, distancia
- Preocupación por la opinión ajena
- Falta de originalidad
- Rigidez en sus convicciones
- Control e inhibición de impulsos
- Posibilidad de relación de las descripciones anteriores con inadaptación social

Puntuaciones bajas son propias de personas que (son):

- Expresivas, inteligentes, expresivas, vigorosas
- Sociables, amigables, carismáticas
- Poco sinceras en sus relaciones
- Gustan de estar relacionadas con mucha gente

- Suelen ser descritas como resentidas y agresivas al tener poco control de impulsos
- Tienen iniciativa, son manipuladoras, oportunistas, atrevidas, exhibicionistas, inmaduras

c) ESCALAS ADICIONALES

FUERZA DEL YO (Es)

A diferencia de otros ítems del MMPI, una puntuación elevada en esta escala sugiere personas estables, carentes de psicopatologías, responsables, adaptabilidad para relacionarse con el medio, realistas, sinceros y perseverantes. Sin embargo, también pueden obtener puntuaciones altas sujetos rebeldes, agresivos, manipuladores o aprovechados.

Puntuaciones bajas sugieren inadaptación, sentimientos de inutilidad y bajo auto concepto, miedos, fobias, tendencia al retraimiento. Asimismo puede interpretarse como exageración de los síntomas para obtener ayuda o comprensión del medio en el que se desenvuelve.

DEPENDENCIA (Dy)

Puntajes altos son característicos de sujetos que son: dependientes, infelices, inconformes, faltos de autoconfianza, tímidos. Por el contrario, puntuaciones bajas sugieren individuos independientes, asertivos socialmente, despreocupados por las opiniones y acciones ajenas.

DOMINANCIA (Do)

Compuesta de 28 ítems puede ser utilizada en selección de personal, puesto que está relacionada con el liderazgo y participación social. Puntajes altos son característicos de sujetos que: manifiestan elevada autoconfianza, buena capacidad de dirigencia y optimistas. Puntuaciones bajas dificultad para enfrentar problemas, baja capacidad de dirigencia, falta de autoconfianza, susceptibilidad a dejarse influenciar con el medio y pesimismo.

RESPONSABILIDAD (Re)

Puntajes altos sugieren que el individuo asume la responsabilidad de sus actos, es confiable, tiene conciencia de grupo, integridad y justo. Puntajes bajos sugieren lo contrario, son personas que cuestionan los valores y reglas establecidos (políticos, morales, religiosos.)

CONTROL (Cn)

Personas con puntuaciones elevadas pueden ser: impulsivas y con malestar, sin tener que padecer de un cuadro clínico. Es importante considerar las puntuaciones en las escalas clínicas para poder establecer relación con las puntuaciones en Cn, puesto que una puntuación elevada combinada con escalas clínicas elevadas sugieren la hospitalización del examinado, por el contrario si las puntuación en Cn es baja y las clínicas lo son también, nos son indicadores de descontrol.

El objetivo principal del presente manual, es el de proporcionar al lector información práctica acerca de la aplicación e interpretación correctas del MMPI, para de esta manera se pueda concebir un resultado final estandarizado y correcto.

2. COMBINACIÓN DE DOS ESCALAS

El MMPI es uno de los inventarios de personalidad que ha generado la realización de diversas investigaciones desde su primera publicación. La *Combinación de dos escalas*, es resultado de diversos estudios que hoy en día facilitan la interpretación del MMPI, puesto que al combinar dos escalas se pueden obtener datos muy importantes acerca del examinado. Una vez realizado el gráfico (véase en subtítulo posterior) se deben encontrar los dos picos más elevados de las escalas clínicas y combinarlos. (véase paso 8 en la interpretación del MMPI)

A continuación se exponen las combinaciones más frecuentes, puesto que oscilan entre 40 combinaciones, demostrando al lector una vez más la gran importancia de este inventario en el diagnóstico de la personalidad del hombre.

Esta combinación representa a sujetos con las siguientes características: Preocupados por su salud, que se sienten muy enfermos ante cualquier signo de malestar físico. Presencia de trastornos digestivos, dolores de cabeza o cardíacos. Manifiestan somáticamente su reacción ante el estrés o problemas de la vida cotidiana. Ansiosos e irritables, pueden expresar timidez, indecisión, dependencia, desdicha, falta de iniciativa o melancolía. Puede existir agresividad reprimida hacia personas indiferentes a sus sentimientos. En pacientes psiquiátricos, se observa adicción al alcohol, causante principal de sus problemas familiares, sociales y laborales. Mal pronóstico en la psicoterapia al tener poca capacidad de insight y evitar asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos.

13/31

Esta combinación es más frecuente en mujeres. Las características principales son las siguientes: Síntomas pertenecientes a la histeria de conversión e hipocondría. Manifestación continua de dolores en la espalda, trastornos digestivos y del sueño, son muy comunes en estas personas. Como mecanismos de defensa, utilizan la negación, racionalización, proyección, y generalmente atribuyen a otros la responsabilidad de sus propios actos. Inmadurez, egoísmo, egocentrismo, inseguridad, necesidad de afecto son comunes. Se observa también dificultad para relacionarse con el sexo opuesto. Puede existir agresividad reprimida hacia personas indiferentes a sus sentimientos o problemas personales. Comportamiento convencional y aceptable al “qué dirán” es frecuente. Mal pronóstico en la psicoterapia al tener poca capacidad de insight y evitar asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos. Creencia de que el psicólogo es el “salvador”, desplazándole la responsabilidad acerca del resultado de la terapia que frecuentemente la finalizan antes de tiempo al no ser satisfechas todas sus expectativas.

14/41

Es más común en el sexo masculino, manifestando las siguientes características: Hipocondría severa. Ansiedad, indecisión, rebeldía, insatisfacción, pesimismo. Manifiestan buen desenvolvimiento social, pero falta de capacidad para relacionarse

con el sexo opuesto. Se observa adicción al alcohol, causante principal de sus problemas familiares, sociales y laborales. En terapia, manifiestan como mecanismo de defensa la Negación, lo que imposibilita el buen desarrollo de la misma.

18/81

Se observan las siguientes características en los sujetos 18/81: Represión de hostilidad manifestada con estados irritables. Desconfianza, aislamiento, desdicha y depresión son manifestaciones comunes. Si el sujeto tiene un cuadro psiquiátrico, puede ser esquizofrénico o esquizoide.

19/91

Esta combinación representa a sujetos con las siguientes características: Ansiedad, confusión e irritabilidad son frecuentes. Somatización. Extroversión, metas altas generalmente acompañadas de frustración.

23/32

Se observan las siguientes características en los sujetos 23/32 (es más frecuente en mujeres que en hombres): Ansiedad adaptativa, depresión y fatiga. Falta de interés para empezar de nuevo. Dependencia y sumisión. Competitivas pero con miedo al fracaso. Susceptibilidad. Autocontrol. Rechazo a las relaciones sociales y con el sexo opuesto. En muy común la obtención de esta combinación en pacientes psiquiátricos con neurosis depresiva, y depresión psicótica ocasionalmente. Mal pronóstico en la psicoterapia al tener poca capacidad de insight. Prefieren "seguir como están" a someterse a psicoterapias desconocidas para ellos.

27/72

Esta combinación representa a sujetos con las siguientes características: Ansiedad, confusión e irritabilidad son frecuentes. Preocupación frecuente hacia los peligros reales o ficticios. Somatización, insomnio, depresión, anorexia, fatiga son comunes. Pesimistas, quejumbrosos, indecisos, inseguros, sumisos y dependientes. Necesidad de logro y éxito. Culpabilidad al no poder cumplir las metas fijadas.

Rígidos y moralistas. Dóciles y con capacidad de establecer vínculos afectivos profundos. Buen pronóstico en psicoterapia.

28/82

Las características principales correspondientes a este perfil son las siguientes: Sujetos ansiosos, temerosos, dependientes, inseguros de sus propias capacidades, irritables, rencorosos, depresivos, etc. Falta de memoria y concentración. Quejas somáticas relacionadas con dolores digestivos, vértigo y ataques de pérdida de conocimiento. Disociación Cognoscitiva. Aislamiento social y falta de compromiso. Si ambas escalas están muy elevadas sugieren sujetos maníaco-depresivos, esquizofrénicos de tipo esquizoafectivo, tendencias suicidas, etc.

29/92

Se observan las siguientes características en los sujetos 29/92: Narcisismo y egocentrismo. Preocupación excesiva de logro y éxito que frecuentemente desemboca en frustración. Crisis de identidad personal y vocacional. Somatización. Utilizan el abusos a las bebidas alcohólicas como escape a la realidad. Depresión encubierta por actividad excesiva. Esta combinación es muy frecuente en pacientes maníaco-depresivos o con daño cerebral.

24/43

Una de las características principales de los sujetos pertenecientes a este perfil, son la agresividad y sentimientos negativos. Si la escala 3 es más elevada que la 4, puede tratarse de un sujeto pasivo-agresivo, por el contrario, escalas más elevadas en 4 sugieren cuadros violentos y agresivos. Este perfil es muy común en sujetos con historiales criminales violentos.

En casos muy raros se observa un buen manejo de la agresividad, sublimándola. En este grupo se observan dolores de cabeza y gastrointestinales. Sensibilidad al rechazo, rencor hacia la familia, rebeldía, inestabilidad en el matrimonio, promiscuidad, tendencias suicidas, consumo excesivo de alcohol, inestabilidad emocional.

36/63

Ansiedad no incapacitante. Dolores físicos leves. Sentimientos reprimidos de rencor profundo y hostilidad hacia la familia, sentimientos justificados en función de la conducta ajena. Personas complicadas, narcisistas, egocéntricos, insoportables y/o resentidos.

38/83

Las características principales correspondientes a este perfil son las siguientes: Ansiedad, temor, preocupación, fobias, depresión, irresponsabilidad, inmadurez, dependencia, falta de decisión, iniciativa y originalidad, pesimismo, apatía. Pensamiento turbado, falta de memoria y concentración, extravagancia, rumiación, alucinaciones, y / o delirios. Quejas físicas y /o insomnio. Presencia de *insight*, pero mal pronóstico en la psicoterapia.

45/54

Se observan las siguientes características en los sujetos 45/54: Inmadurez, narcisismo, dependencia, rebeldía, extravagancia, baja tolerancia a la frustración, bajos niveles de agresividad, resentimiento, remordimientos, posible confusión en relacionada con la identidad y roles sexuales, machismo (en los hombres). En pacientes psiquiátricos generalmente se observa diagnóstico de personalidad pasiva-agresiva.

46/64

Inmadurez, narcisismo, irritabilidad, rencor, resentimiento, agresividad reprimida, dependencia, necesidad de atención y afecto solo para sí mismos. Las mujeres manifiestan conductas femeninas estereotipadas. Incomodidad en encuentros sociales y de pareja. Dificultad para establecer compromisos emocionales y matrimoniales. Deficiencia laboral. Como mecanismos de defensa frecuentes se manifiestan racionalización, negación y desplazamiento de la culpa hacia los demás.

En pacientes psiquiátricos generalmente se observa diagnóstico de personalidad pasiva-agresiva, esquizofrenia de tipo paranoide, depresión, irritabilidad, ansiedad, quejas frecuentes de malestar físico.

47/ 74

Preocupación y posterior indiferencia hacia las consecuencias de los propios actos. Abuso de bebidas alcohólicas, promiscuidad sexual seguidos de sentimientos de culpa. Dependencia e inseguridad. Quejas frecuentes de malestar físico. La psicoterapia puede ser favorable, aunque se observan cambios impredecibles en la personalidad.

48/84

Inadaptación, extravagancia, rebeldía, convicciones radicales, impredecibles, impulsivos, manipuladores, interesados, desconfiados, irritables, rencorosos, pueden manifestar conductas antisociales, agresivos, fríos y calculadores a la hora de pensar o ejecutar un crimen, promiscuidad y desviación sexual, adicción a drogas, y fracaso constante. Inseguridad, predisposición al fracaso y dependencia son frecuentes, cuadros suicidas, tendencia al asilamiento, culpan a los demás por las consecuencias de sus propios actos. Los individuos con perfil 48/84 manifiestan inseguridad en relación con su propia sexualidad, conductas sexuales agresivas y/ o pensamientos constantes acerca del propio desenvolvimiento sexual.

En pacientes psiquiátricos generalmente se observa diagnóstico de personalidad antisocial o esquizoide, esquizofrenia de tipo paranoide, y/ o excentricismo.

49/94

Rebeldía, conducta antisocial, promiscuidad, adicciones, problemas de pareja, narcisismo, impulsividad, desconfianza, irresponsabilidad, delegación constante de las propias responsabilidades, poca tolerancia al fracaso, irritabilidad, agresividad, y resentimiento. Dificultada para establecer vínculos profundos y sinceros. Crean una buena impresión al ser conversadores, son muy activos. En pacientes psiquiátricos generalmente se observan diagnósticos maníaco-depresivos, trastorno de personalidad antisocial e inestabilidad emocional.

68/86

Se observan las siguientes características en los sujetos 68/86: Inseguridad, dependencia, aislamiento, extravagancia, falta de autoconfianza y autoestima, apatía, y posibles tendencias suicidas. Dificultad para comprometerse y establecer vínculos emocionales con otras personas. En pacientes psiquiátricos son comunes los trastornos de personalidad esquizoides, esquizotípicos o paranoides, y esquizofrenia.

69/96

Dependencia, vulnerabilidad ante el peligro real o ficticio, ansiedad, irritabilidad, tendencia a refugiarse en la fantasía, autocontrol seguido de impulsividad son frecuentes. En pacientes psiquiátricos es común la esquizofrenia paranoide, trastornos de pensamiento, obsesiones, poca capacidad de concentración, desorientación en el tiempo y el espacio.

78/87

Depresión ansiedad, confusión ante situaciones nuevas son comunes. Inseguridad, dependencia, incapacidad para relacionarse con el sexo opuesto, fantasías sexuales frecuentes, bajo desempeño sexual. Trastornos obsesivo-compulsivos, esquizoides, maníaco –depresivos son comunes. Vale mencionar que mientras más elevada sea la escala 8, más síntomas psicóticos tendrá el examinado.

89/98

Infantilismo, egocentrismo, narcisismo, dependientes, rencorosos y hostiles cuando no son satisfechas sus demandas. Incapacidad de establecer relaciones profundas con tendencia al aislamiento. En examinados se observa adicción a drogas. En psicoterapia se observa negación de los síntomas perjudicando de esta manera el proceso psicoterapéutico. Si las escalas son muy elevadas sugieren trastornos psicóticos.

3. OTROS PERFILES FUNDAMENTALES

Los siguientes perfiles son obtenidos con más de dos escalas con puntuaciones T superiores a 70, cualquier omisión a e esta regla será explicada prudentemente.

1-2-3

Síntomas pertenecientes a la Hipocondría, ansiedad, poca autoconfianza, tendencia al aislamiento, convicciones rígidas. Es común la somatización para obtener beneficios primarios o secundarios.

1-3-2

Sujetos pasivo-dependientes, ansiosos, extrovertidos, simpáticos, irritables, manifiestan cuadros somáticos para obtener beneficios secundarios o primarios. Bajo nivel de adaptabilidad ante situaciones nuevas y agresividad reprimida son frecuentes.

1-3-8/1-3-8-2

Hostilidad, ansiedad, tendencias suicidas, convicciones rígidas, celos, suspicacia y desconfianza son muy comunes en las personas pertenecientes a este perfil. En pacientes psiquiátricos es común la esquizofrenia de tipo paranoide. Mal pronóstico en psicoterapia.

2-7/2-7-3

Ansiedad, perfeccionismo, obsesión por el orden y la limpieza, rigidez, vulnerabilidad ante grandes responsabilidades, baja autoestima, tendencias suicidas, agresividad, depresión, trastorno de sueño, dificultad para establecer relaciones profundas y adicciones son características frecuentes en los sujetos pertenecientes a este perfil.

278

Conductas particulares de sujetos esquizoides, depresión, obsesiones, falta de concentración son frecuentes. Este perfil generalmente es obtenido por sujetos heterosexuales.

8-1-2-3

CI más bajo del común cuando L es superior a T 70. Hostilidad, poca capacidad de adaptabilidad, aislamiento y confusión mental son frecuentes. En pacientes

psiquiátricos es común el trastorno de personalidad esquizoide, esquizofrenia simple, paranoide o crónica.

8-2-4/8-2-4-7

Inmadurez, irritabilidad, agresividad, desconfianza, gusto por las bebidas alcohólicas, dificultad para establecer relaciones de pareja e irresponsabilidad son frecuentes. Se observa con frecuencia este perfil en pacientes con trastornos paranoides.

4. PERFILES FRECUENTES DE PERSONAS NORMALES

Los perfiles frecuentes de personas normales son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5 y 0 con puntuaciones T moderadas.

5. INTERPRETACIÓN DEL MMPI EN 10 PASOS

A continuación se describe paso a paso, y sobretodo gráficamente, el correcto proceder al interpretar el MMPI.

El presente caso corresponde a un sujeto de 26 años de edad, perteneciente al sexo masculino. Su historial clínico responde a una persona sin psicopatologías de ningún tipo, teniendo como única intervención médica una operación de las amígdalas. En el momento de la exploración, nuestro entrevistado se mostró en un principio muy colaborador, manifestando inseguridad y poca colaboración en el segundo encuentro (Tardó dos horas y media en responder al inventario.)

1. Una vez que se tienen todas los reactivos respondidos, se deben contar meticulosamente los espacios en blanco, o los que el examinado haya respondió falso y verdadero. Todas las respuestas que correspondan a la anterior descripción, serán colocadas en la parte superior izquierda de la hoja de respuestas (¿)
2. Utilizando las respectivas plantillas se deben contabilizar todas las repuestas para cada escala. Es importante que el examinador sea muy cauteloso, y si es posible cuente más veces para evitar cualquier tipo de error. Después, procede a colocar el número de respuestas en la respectiva casilla por escala en la hoja de respuestas.

3. El número obtenido en Factor corrector K, se los debe encontrar en *Fracciones*, ubicado en la parte media de la hoja del gráfico. Este paso es muy importante puesto que las fracciones correspondientes a K, servirán para graficar correctamente. En este caso, nuestro entrevistado obtuvo 19 K, por lo que corresponderían las fracciones de la fila 12 contando desde arriba.
4. Como nuestro entrevistado pertenece al sexo masculino, se procede a realizar el gráfico en parte izquierda de la hoja, que de lo contrario, si hubiese sido mujer, abarcaría la parte derecha. Como paso siguiente, se colocan los valores obtenidos por escala en cada una de las casillas ubicadas en la parte superior de la hoja (debajo de los datos personales.)
5. Se coloca el número respectivo de cada fracción K para que después de sumadas con las puntuaciones directas, se obtenga las puntuaciones corregidas. Este paso es sencillo, pero se debe tener mucho cuidado al ubicar los números en las casillas correctas, puesto que cualquier error significaría un mal gráfico, y por consiguiente un perfil errado.
6. En este paso se procede a graficar. Se ubican los puntos utilizando los números de las escalas con *puntuaciones directas* y *puntuaciones las corregidas*, tal y como se muestra en el gráfico correspondiente (para evitar cualquier equivocación, se recomienda utilizar una regla.)
7. Código de Welsh. Este código fue creado por Welsh con el objetivo principal de que otros examinadores puedan reproducir el gráfico.***
8. Una vez terminado el gráfico, se procede con la respectiva interpretación del mismo. Para ello se requiere que el examinador domine las escalas, y pueda establecer relaciones inteligentes entre los picos más altos y más bajos. Se utiliza la *Combinación de dos escalas*, mencionadas en párrafos anteriores, para finalizar el perfil. Para esto, el psicodiagnosticador debe dominar el número correspondiente a cada escala:

Hs – 1	Pa – 6
D – 2	Pt – 7
Hi – 3	Es – 8
Pd – 4	Ma – 9
Mf – 5	Is – 0

Se deben tomar en cuenta las elevaciones únicas y establecer el perfil de acuerdo a la descripción respectiva de las escalas. En nuestro ejemplo, se obtuvo la combinación 46/64 al tener los picos más llevados en la escalas correspondientes a Paranoia y Desviación Psicopática.

9. En el reverso de la hoja, tenemos los Factores de Segundo Orden, los cuales sirven para estimar los niveles de *Neuroticismo*, *Psicoticismo* e *Introversión*.

Primero se deben anotar todas las puntuaciones T de las escalas clínicas. Por ejemplo, nuestro entrevistado obtuvo 12 de puntuación corregida en Hs, entonces colocando una regla en la columna T, se obtiene como puntuación T para Hs, 47.

Una vez que se han llenado todas las casillas se multiplican las puntuaciones T con los números que se encuentran al lado, anotando el resultado en las casillas blancas. Después se suman todos los resultados de la primera columna, y se los restan con los de la siguiente columna, obteniendo de esta manera el nivel de Neuroticismo del examinado, que es un total 55,3.

Los otros niveles (Psicoticismo, Introversión) se los obtiene de la misma manera, utilizando siempre las puntuaciones T de las escalas clínica y realizando las operaciones matemáticas correspondientes.

Después de realizadas las respectivas multiplicaciones, sumas y restas, obtenemos 40, 1 en Psicoticismo; y 40, 9 en Introversión. Gracias a las anteriores cifras, se concluye que el entrevistado está en el margen neurótico. Muchos pacientes esquizofrénicos generalmente obtienen puntuaciones elevadas en Psicoticismo, de esta manera es importante que las operaciones matemáticas sean realizadas con mucha cautela, puesto que cualquier error, por más mínimo que sea, situaría al examinado en niveles a los que no pertenece.

VARON

Escala	Punt T	Neuroticismo		Psicoticismo		Introversi3n	
		+	-	+	-	+	-
Hs		4					1
D		2			1	4	
Hy		6			1		1
Pd		1		2			
Pa				3			
Pt		1		2		2	
Sc				3		1	
Ma			1	4			2
Si			1			6	
Constante			10		70		43
		+		+		+	
		-		-		-	

10. A continuación se describirán dos tipos de informes: el primero dirigido hacia el mismo sujeto o sus familiares, y el segundo solicitado con fines legales. En ambos casos, como todo informe psicológico los perfiles a presentar deben estar redactados con un lenguaje sencillo que sea de fácil comprensión a personas ajenas a la Ciencia psicológica.

1. El informe debe contener la siguiente información independientemente de los datos del examinado: Actitud hacia la prueba, Síntomas y características de la personalidad, Impresión Diagnóstica y consideraciones de tratamiento.

Si se ha invalidado el perfil, se deben especificar claramente las consideraciones para tal cometido.

2. Las partes que componen un informe psicológico pericial son las siguientes:

Parte inicial. Es el encabezado donde se exponen los datos personales y profesionales del perito. También incluye el nombre a quien va dirigido el informe, fechas, numeraciones y los objetivos planteados para la pericia.

I Parte Expositiva. Número de sesiones realizadas. Antecedentes personales que incluyen aspectos biográficos, patobiografía, antecedentes familiares psicopatología actual, fundamentos psicobiológicos y los estudios psicológicos realizados. En este punto, se debe realizar un pequeño resumen informativo acerca de qué es el MMPI u otra prueba que se haya aplicado.

II Parte Reflexiva. Consideraciones Clínicas. En este punto se realiza un resumen de todos los datos obtenidos en las entrevistas tanto al sujeto como a los familiares, resultados de las pruebas psicológicas y la relación de toda la información con el DSM- IV, estandarizando de esta manera el diagnóstico a un lenguaje psicológico universal. Consideraciones Médico-Legales. En este punto se responde concretamente a la solicitud realizada por el juez o fiscal.

III Conclusiones. Independientemente de los aspectos legales, el perito concluye objetivamente el informe estableciendo relaciones de la posible psicopatología del sujeto y la medida en que esto afecta en sus relaciones, la relación con los hechos y otras cuestionantes relacionadas con el peritaje. Nunca se afirma o niega, puesto

que esta es la labor del juez quien dictaminará con bases legales la relación del hecho con el individuo.

Al tratarse de asuntos legales es necesario que los psicólogos forenses sean calificado, objetivos y ante todo sepan guardar la respectiva discreción de los resultados independientemente del delito del que estén acusados. Es importante que el perito forense se mantenga actualizado, puesto que la negligencia profesional es muy mal vista en un juzgado y puede ser una carta a jugar de la parte contraria. Antes del juicio es importante que el psicólogo forenses se prepare eficientemente para responder clara y concretamente las preguntas de la parte opositora, evitando de esta manera cualquier discrepancia entre lo escrito en el informe y lo expuesto en la corte. Un aspecto que muchas veces no es considerado es el número de encuentros entre el perito y el examinado para la ejecución de la exploración, se aconseja al menos tres encuentros para las entrevistas y aplicación de la batería de test previamente diseñadas de acuerdo a la demanda solicitada, puesto que si solo se tuvo un encuentro, la parte contraria puede hacer que se invalide el informe presentado.

OTRA FORMA DE INTERPRETACION DEL CUESTIONARIO MMPI (S.R. Hathaway y J.C. Mckinley en 1943)

Razones de puntajes elevados en la escala (?)

- 1.- Dificultades de lectura
- 2.- Estados psiquiátricos en los que hay un alto grado de confusión o distractibilidad
- 3.- Estados de alerta o suspicacia, por ejemplo, pacientes paranoides.
- 4.- Depresión severa que refleja retardo psicomotor o aletargamiento.
- 5.- Sujetos rebeldes o no cooperadores, por ejemplo adolescentes.
- 6.- En algunas ocasiones, cuando se permite omisión , por ejemplo, en selección de personal, items muy personales se omiten con frecuencia.
- 7.- Personas obsesivas o extremadamente intelectualizaras, que no pueden tomar decisiones.

Posibles razones para elevación en la escala L

1. Nivel socio-económico bajo del sujeto.
2. Miembro de grupos subculturales
3. Inteligencia limitada
4. Distorsión consciente o deliberada del test
5. Neurosis

Correlatos de personalidad para escala L elevada

1. Falta de insight personal
2. Ingenuidad
3. Caracterizado por negación. El puntaje L elevado está frecuentemente asociado con un ajuste histeroide.
4. Adaptación rígida
5. Necesidad de presentar una buena imagen, o causar buena impresión.

Algunos correlatos de personalidad en sujetos normales con bajo L.

1. Confianza en sí mismo, e independencia
2. Sensibilidad social
3. Ocasionalmente sarcástico
4. Muestran serenidad y tranquilidad al admitir sus faltas.

Razones para escala F elevada.

1. Respuestas al azar de los items (uno puede esperar un puntaje F. Cercano a 32 puntos brutos.
2. Respuestas alteradas debido a falsificación o a pretender demostrar enfermedad mental. Este tipo de personas tiende a exagerar y produce una escala F elevada y un perfil dentado.
3. Bajo nivel de lectura que se traduce en no comprensión de los items.
4. Errores de puntuación en el perfil.
5. Los adolescentes presentan típicamente un puntaje F elevado
6. Los psicóticos a menudo producen puntajes F elevados.
7. Personas que están siendo sometidas a una fuerte tensión a menudo producen puntajes F elevados (por ejemplo: crisis de identidad en adultos jóvenes).
8. El puntaje F elevado puede relejar el grito de ayuda de un individuo.
9. El puntaje F elevado puede proporcionar indicación de la gravedad del desorden psicológico.

Posibles razones para puntajes K elevados

1. Personas de nivel socio-económico elevado tienden a producir altos puntajes de K.
2. En la población normal, un elevado k refleja:
 - a) Auto – aceptación
 - b) Auto – suficiencia
 - c) No autoritarismo
3. Gran fuerza del Yo
4. Defensividad general, retraimiento, reacio a admitir debilidades personales.
5. En situaciones donde se evalúa a sujetos normales (admisión al colegio, selección de personal), puede esperarse que la escala K se encuentre elevada.

En estas situaciones los puntajes bajos de K deber ser evaluados cuidadosamente.

Hipótesis relacionadas con rangos de puntajes K para una población psiquiátricas.

0 - 8 K en pacientes de nivel socio-económico bajo, uno puede esperar una perturbación moderada. En pacientes de nivel socio-económico alto un bajo K refleja disminución de la fuerza del yo. Pacientes con bajo K tienden a ser muy accesibles y a menudo son confesos masoquistas.

A menudo están descontentos, tienen modales cáusticos y son quejumbrosos. El pronóstico para el tratamiento es generalmente pobre.

8 - 15 K El sujeto normal típico y muchos pacientes psiquiátricos tienen puntajes dentro de este rango. Una cierta elevación de K es de buen pronóstico y sugiere adaptabilidad y fuerza del yo.

15 – 25 K Pacientes muy defensivos, que se caracterizan por mecanismos negación – histeroides.

25 – 30 K Los puntajes en este rango son muy poco frecuentes. Estos pacientes muestran una tendencia extrema a no admitir problemas o debilidades. Este tipo de personas no tienen insight psicológico. El tratamiento tiene mal pronóstico.

Características de los pacientes con altos puntajes en la escala 1

1. Tiene excesiva preocupación por el cuerpo, numerosos síntomas somáticos que generalmente son vagos. Si los síntomas son específicos es probable que sean epigástricos.
2. Quejas de fatiga crónica, dolor y debilidad
3. Es probable que se le dé un diagnóstico de neurosis (hipocondríaco, neurosténico, depresivo, estado de conversión).
4. Generalmente carece de ansiedad manifiesta.
5. Egoísta, egocéntrico, narcisista.
6. Tienen una visión pesimista, derrotistas y cínica.
7. Descontento, infeliz, pesimista, actitud amarga frente a la vida
8. Quejumbroso, exigente.
9. Expresa la hostilidad indirectamente, a menudo critica a los otros
10. Hace desdichados a los que lo rodean
11. Rara vez actúa en forma psicopática.
12. Aburrido, poco entusiasta, poco ambicioso, a menudo es inefectivo en su expresión con pocas ambiciones, oral.
13. Generalmente tiene problemas de larga duración. A menudo no demuestra gran incapacidad, pero parece estar funcionando con una muy baja. Generalizada en el nivel de eficiencia.
14. Rigidez de pensamiento.
15. Frecuentemente no responde a la psicoterapia debido a falta de insight y poca disposición psicológica y por una visión cínica y crítica del terapeuta.
16. Frecuentemente es derrotista respecto a la terapia, se retirará si considera que el terapeuta no le da la atención y el apoyo suficiente a sus dolencias físicas.

Características de sujetos con puntajes bajos en Hs.

1. Libre de preocupaciones somáticas
2. Optimista
3. Capacidad de insight y sensibilidad
4. Generalmente efectivo en la vida diaria

Características de personalidad asociadas con puntajes elevados en la escala 2 (D).

1. Reporta sentimientos de tristeza, depresión, infelicidad, disforia.
2. Se siente inútil e incapaz de funcionar
3. Generalmente es pesimista acerca del futuro
4. Preocupado por sentimientos de culpa
5. Falta de confianza en sí mismo, hace frecuentemente comentarios auto-deprecatorios.
6. Puede rehusar hablar, llora a menudo, aparece perezoso o lento en sus movimientos.
7. Introverso, reservado, tímido, retraído, solitario, distante.
8. Frecuentes quejas somáticas, puede reportar debilidad, fatiga, pérdida de energía.
9. Se preocupa en exceso, muestra sentimientos de inseguridad.
10. Puede parecer agitado, tenso, irritable, de mal ánimo.
11. Dificultad para tomar decisiones.
12. No agresivo, puede hacer concesiones para evitar enfrentamientos.
13. Mantiene distancia psicológica, evita compromisos interpersonales.
14. Cauteloso, convencional, sobrecontrolado.
15. Diagnóstico de depresión (generalmente neurosis depresiva o depresión reactiva).
16. Niega impulsos
17. Evita las cosas desagradables
18. Una de las más frecuentes espigas (puntaje alto) en cuadros psiquiátricos.
19. Asociados con baja tasa de delincuencia
20. Muy frecuentemente elevada en pacientes de edad
21. Debido a disconfort subjetivo, probablemente motivado para psicoterapia
22. Riesgo de suicidio (Depende de los puntajes en otras escalas).

Características de sujetos con puntajes bajos en escala 2.

1. Confianza en sí mismo. Autocontrol.
2. Se siente cómodo y relajado
3. Libre de tensiones, ansiedad, culpa y depresión.
4. Emocionalmente estable, alegre y optimista.
5. Funciona en forma efectiva en la mayoría de las situaciones
6. Alerta, activo, enérgico, tiene pocas dificultades en la expresión verbal.
7. Competitivo, asume responsabilidades, asume roles de liderazgo.

8. Se siente cómodo en situaciones sociales
9. Hábil, astuto, ingenioso, pintoresco
10. Crea primera impresión favorable.
11. Impulsivo, descontrolado, desinhibido, petulante, exhibicionista.
12. A menudo tiene conflictos con figuras de autoridad
13. Puede generar hostilidad y resentimiento en los demás

Características asociadas con escala 3 (Hy) elevada

1. Reprimido, excesivamente controlado.
2. No expresa abiertamente hostilidad y resentimiento.
3. Utiliza medios desviados e indirectos para obtener afecto y atención.
4. Reacciona al stress y evita responsabilidades desarrollando síntomas físicos.

A menudo tiene dolores de cabeza, dolores al pecho, debilidad, taquicardia y ataques de angustia.

El 75% de las mujeres se someten a histerectomías. Los síntomas a menudo aparecen y desaparecen bruscamente.

5. Falta de insight respecto a los propios motivos, sentimientos y causas de los síntomas.
6. Baja capacidad de reflexión psicológica, lento en llegar a insight sobre la causa de su propia conducta.
7. Ausencia de ansiedad.
8. Muestra poca tensión o depresión
9. Tiene problemas matrimoniales o familiares
10. A menudo tiene problemas con la autoridad.
11. Tiene historia de rechazo en la familia
12. Rara vez reporta alucinaciones, delirios y suspicacia;
13. Si es un paciente psiquiátrico, el diagnóstico más frecuente es de neurosis histérica o conversión histérica.
14. Extremadamente egocéntrico y narcisista.
15. Psicológicamente inmaduro, infantil, pueril.
16. Manipulador.
17. Exige atención y cariño de los demás.
18. Socialmente activo, amistoso, conversador, entusiasta, alerta.
19. Generalmente tiene relaciones interpersonales superficiales e inmaduras.
20. A menudo interesado en las personas debido a lo que puede obtener de ellas.
21. A menudo no se siente aceptado por su grupo social.
22. Ingenuo
23. Ocasionalmente actuación externa (acting out) sexual o agresivo con poco insight aparente de sus actos.
24. Generalmente entusiasta respecto al tratamiento.

25. Generalmente responde bien a los consejos o sugerencias, pero resistente a la interpretación psicológica y al tratamiento.

Características asociadas con bajos puntajes en la escala 3.

1. Tiene un rango de intereses estrecho y participación social limitada.
2. Constreñido, convencional, conformista, poco aventurado, poco industrial.
3. Evita rol de líder.
4. Realista, lógico, acercamiento cerebral a los problemas.
5. Poco amistoso, testarudo, difícil de conocer.
6. Parece contentarse con un tipo de vida monótona, sin grandes acontecimientos. El individuo con bajo puntaje en esta escala tiende a ser muy crítico de sí mismo y corrientemente está descontento de sí sin motivo. Acepta consejos y sugerencias. Aunque inicialmente puede responder bien a la psicoterapia, tiende a volverse muy dependiente del tratamiento y a menudo le asusta, acepta la responsabilidad de su propia conducta.

Características asociadas con puntajes altos en escalas 4 (p d)

1. Falta de conformidad social
2. Realiza conductas asociales y antisociales: Mentiras, estafas, robos, acting out sexuales, uso excesivo del alcohol y/o drogas, excesivo gusto por el juego.
3. Actúa impulsivamente sin considerar las consecuencias de sus actos.
4. No planea bien; no puede aprender de la experiencia.
5. Muestra un discernimiento pobre, corre riesgos.
6. Rebeldía hacia figuras de autoridad.
7. Tiene relaciones familiares tormentosas.
8. Impaciente, limitada tolerancia a la frustración, inmadurez, puerilidad, insatisfacción.
9. Ausencia de respuesta emocional profunda. Se aburre.
10. Incapaz de entablar relaciones afectivas, relaciones interpersonales superficiales o poco profundas.
11. Insensible hacia los demás
12. Extrovertido, conservador, activo, arriesgado, enérgico, espontáneo, desenvuelto.
13. Narcisista, egocéntrico, egoísta, exhibicionista
14. Generalmente interesado en los demás para utilizarlos
15. Simpático, crea primera impresión buena, seguridad en sí mismo.
16. Dificultades con la Ley. "Acting out".
17. Antagónico, hostil agresivo, cínico, sarcástico, rebelde, resentido.
18. Tiene explosiones de agresividad, conducta de ataque.
19. Experimenta poca culpa por su conducta pero puede fingir culpa y remordimiento cuando se encuentra en problemas.
20. Generalmente libre de angustia desorganizadora, depresión y síntomas psicóticos.

21. Probable diagnóstico de personalidad antisocial, personalidad pasivo-agresiva, alteración de la personalidad.
22. Tiene una historia de bajo rendimiento escolar y una deficiente historia laboral.
23. Presenta problemas matrimoniales.
24. Culpa a sus padres o a otros de sus problemas.
25. Utiliza la intelectualización y la negación.
26. Tiene mal pronóstico para psicoterapia.
27. Puede acceder al tratamiento para evitar la cárcel y otra experiencia desagradable, pero probablemente lo terminará en forma prematura.
28. Los adolescentes a menudo tienen puntajes altos en estas escalas.
29. Asociada con alta tasa de delincuencia.
30. Las mujeres tienen embarazos fuera del matrimonio.

Características asociadas con puntajes bajos en escala 4 (4Pd)

1. Convencional, conformista, aceptadora de la autoridad, pasivo, sumiso, no asertivo, inaccesible.
2. Inhibido
3. No creativo o espontáneo.
4. Preocupado de la reacción de los demás
5. Sincero, confiado, perseverante.
6. Tiene poco empuje, no es competitivo
7. Si es hombre, poco impulso sexual, puede temer a las mujeres.
8. Preocupado por el status y la seguridad.
9. Moralistas, rígido, limitado.
10. Auto-crítico, insatisfecho de sí mismo.
11. Dócil, acepta consejos y sugerencias.
12. Puede volverse muy dependiente en el tratamiento.
13. Temeroso de aceptar la responsabilidad de su propia conducta.
14. Necesita apoyo, que lo reafirmen.

Características asociadas con puntajes altos en la escala 5 (Mf) Hombres

1. Afeminado, presenta conflictos acerca de su identidad sexual, inseguros en el rol masculino, tendencia homo-erótica.
2. Tiene intereses artísticos y estéticos
3. Inteligente, capaz, valora logros cognitivos
4. Ambicioso, competitivo, perseverante
5. Demuestra buen juicio, sentido común.
6. Curioso, creativo, imaginativo e individualista en la aproximación de los problemas.
7. Sociable, sensible hacia los demás, capaz de expresar sentimientos de calidez hacia los otros.
8. Tolerante
9. Pasivo, dependiente, sumiso en las relaciones interpersonales.
10. Amante de la paz, hace concesiones para evitar confrontaciones.

11. Tiene buen auto control, acting-out es poco frecuente

Características de puntajes altos en escala 5 (Mujeres)

1. Rechazo al rol tradicional femenino, tiene intereses masculinos en el trabajo, deportes y hobbies.
2. Activa, vigorosa, asertiva, poco amistosa.
3. Competitiva, dominante, agresiva.
4. Ruda, poco emotiva, tosca, fuerte.
5. Desinhibida, confía en sí misma. Desenvuelta.
6. Lógica, calculadora.
7. Fácil de llevar, relajada, equilibrada.

Características de puntajes bajos en escala 5 (Hombres)

1. Se presenta como extremadamente masculino, excesivo énfasis en la fuerza y fuerzas físicas.
2. Puede tener dudas sobre su propia masculinidad.
3. Tiene un estrecho rango de intereses o inteligencia limitada.
4. Rudo, vulgar, tosco.
5. Agresivo, busca emociones, aventurero, temerario
6. Prefiere la acción al pensamiento
7. Poco flexible y poco original en la resolución de los problemas
8. Práctico, no teórico
9. Contento consigo mismo, desea establecerse.
10. Fácil de llevar, relajado, disfruta la vida recreativa.
11. Alebre, de buen humor, contento.
12. Despreocupado del valor de los estímulos sociales.
13. Carencia de insight sobre sus motivos.

Características de puntajes bajos en escala 5 (Mujeres)

1. Se describe a sí misma en términos de un rol femenino estereotipado
2. Sumisa, sometida, constreñida. Pasiva.
3. Deja a los hombres la toma de decisiones.
4. Auto compasiva, quejumbrosa, crítica
5. Sensible
6. Modesta
7. Idealista

Características de los puntajes marcadamente elevados en la escala 6 (Pa con T = 75)

1. Muestra perturbaciones del pensamiento y manifiesta conductas francamente psicóticas.
2. Tiene delirios de persecución y/o de grandeza, o ideas de referencia.
3. Se siente maltratado.
4. Enojado, resentido, rencoroso
5. El o ella sienten que saben quién es el responsable de su problema.
6. Utiliza la proyección como mecanismo defensivo.
7. Externaliza culpas
8. Hostil
9. Diagnóstico más frecuente: esquizofrenia o estado paranoídeo
10. Difícil de tratarse psicológicamente: respuesta pobre al tratamiento.

Características de los puntajes moderadamente elevados en la escala 6 (Pa con T = 70 - 75)

1. Hostilidad; resentimiento hacia la familia.
2. Demasiado sensible a las reacciones de los demás.
3. Moralista, rígido.
4. Religiosidad.
5. Racionaliza; proyecta la culpa hacia otros por sus propios problemas
6. No le gusta hablar de problemas emocionales
7. Siente que la vida lo trata mal
8. Ideación paranoídea. Desconfiado, defensivo.
9. Hostil, resentido, discutiendo.
10. Tiene dificultades para establecer rapport con el terapeuta.
11. Personalidad paranoídea/carácter paranoídeo.

Características de puntajes bajos en la escala 6 (Pa con T 35)

1. Demasiado sensible, evasivo, defensivo, desconfiado.
2. Tímido, reservado, retraído.
3. Puede tener delirios, ideas de referencia.
4. Puede presentar un desorden francamente paranoídeo.

Características de puntajes altos en la escala 7 (Pt)

1. Ansioso, tenso, agitado, preocupado, aprensivo.
2. Muy tenso, "saltón"
3. Frecuentemente siente confusión y malestar agudo.
4. Se siente inseguro e inferior
5. Tiene dificultades en la concentración
6. Introspectivo, rumiando.
7. Obsesivo en su pensamiento
8. Tiene conductas compulsivas

9. Puede manifestar conductas fóbicas
10. Reacciona en forma excesiva a los problemas, distorsiona la importancia de ellos
11. Rígido
12. Tiene dudas sobre si mismo, autocrítico, consciente de si, auto despreciativo, carente de confianza en si mismo.
13. Vacila, tiene dificultad incluso para tomar decisiones de rutina
14. Perfeccionista, concienzudo, moralista, tiene altas exigencias, para sí y para los demás.
15. Persistente, a menudo persevera en un grado anormal.
16. Super-yo severo.
17. Deprimido, propenso a la culpa.
18. Pulcro, ordenado, organizado, meticoloso.
19. Confiable, recto.
20. Carente de ingenuidad y originalidad en el acercamiento a los problemas.
21. Dependiente.
22. Demasiado formal, convencional, aburrido.
23. Tímido.
24. No interactúa bien socialmente, difícil de conocer.
25. Sentimental, confiado, sensible, blando de corazón.
26. Quizás inmaduro.
27. A menudo presenta varias dolencias físicas:
 - a) corazón
 - b) Genito – urinarias
 - c) Gastro – intestinales
 - d) Fatiga, insomnio, agotamiento
28. Intellectualiza, racionaliza, rumia sus problemas.
29. Muestra cierto insight respecto a los problemas
30. No responde bien a psicoterapia breve.
31. Resistente a las interpretaciones en psicoterapia
32. A menudo expresa hostilidad al terapeuta
33. Permanece en psicoterapia más tiempo que la mayoría de los pacientes.
34. Generalmente buen pronóstico en psicoterapia.

Características de puntajes bajos en escala 7

1. Capaz, bien adaptado
2. Generalmente libre de miedo y ansiedad desorganizadora
3. Confianza en sí mismo, seguridad en sí mismo.
4. Responsable, eficiente, realista, adaptable.
5. Valora el éxito, el status y el reconocimiento, tiene un amplio rango de intereses.

Características de puntajes altos en la escala 8 (Sc)

1. Retraído, solitario, reservado.
2. Evita relacionarse con gente y situaciones nuevas

3. Tímido alienado, huraño, no comprometido, inaccesible, se siente rechazado por sus iguales.
4. Se siente solo, incomprendido.
5. Confuso, desorganizado, desorientado.
6. Tiene pensamientos o actitudes poco corrientes, ideación bizarra, perturbaciones del pensamiento.
7. Tiene alucinaciones / delirios.
8. Tiene un estilo de vida excéntrico, esquizoide
9. Pude manifestar conducto sicótica abiertamente
10. Manifiesta ansiedad generalizada; manifiesta alta tensión.
11. Reacciona frente a las lesiones, refugiándose en ensueños y fantasías
12. Incapaz de expresar sentimiento, a menudo presenta rominaciones circunstanciales.
13. Dificultades en las relaciones interpersonales
14. Demuestra tener poco criterio
15. Se siente resentido, hostil, agresivo.
16. Inconformista, no convencional, excéntrico, pero corriente.
17. Testarudo, irritable, obstinado.
18. Inmaduro, impulsivo.
19. Lleno de dudas sobre sí mismo, sentimientos de inferioridad, incompetencia, insatisfacción.
20. Tiene preocupaciones sexuales, confusión de roles sexuales.
21. Tiene metas abstractas, a menudo irreales y vagas; bajo rendimiento.
22. Creativo, imaginativo, pensamiento fluido.
23. Carece de información básica requerida para resolver problema.
24. Quejas por malestares físicos que son vagas y de larga duración.
25. A menudo incapaz de relacionarse con el terapeuta de manera significativa.
26. Respuesta pobre a la psicoterapia, puede permanece en psicoterapia por más tiempo que la mayoría de los pacientes.

Características de puntajes bajos en la escala 8

1. Cauteloso, convencional, conservador, poca imaginación en su manera de enfrentar los problemas.
2. Práctico.
3. Preocupado acerca del éxito, del status, del poder.
4. Responsable, confiable.
5. Equilibrado, adaptable.
6. Amigoso, alegre, de buen genio, sensible, confiable.
7. Sumiso, complaciente, demasiado aceptador de la autotridad.

Características de puntajes elevados en la escala 9 (Ma)

1. Enérgico, conversador.

2. Desenvuelto, socialbe, gregario, le gusta estar rodeado de gente.
3. Optimista, poco realista, sin fundamento.
4. Exagera su propio valor e importancia; equilibrado, tiene confianza en sí mismo.
5. Amistoso, agradable, entusiasta.
6. Manifiesta excesiva actividad, sin propósito, puede tener lenguaje acelerado.
7. Tiene alucinaciones / delirios de grandeza
8. No utiliza la energía inteligentemente, se extiende demasiado, no completa los proyectos.
9. Tiene Aspiraciones y planes grandiosos
10. Incapaz de ver las propias limitaciones
11. Tiene poco interés en la rutina o en detalles, se aburre e irrita fácilmente
12. Baja tolerancia a la frustración
13. Tiene un amplio rango de intereses, realiza diversas actividades
14. Emprendedor, creativo, ingenioso
15. Causa primera impresión buena
16. Tiene dificultades en el colegio o trabajo, conductas delictuosas
17. Puede comprometerse en actos antisociales graves
18. Tiene episodios de irritabilidad, hostilidad, explosiones agresivas.
19. Tiene dificultades para inhibir la expresión de los impulsos.
20. Manipulador, engañoso, poco confiable.
21. Se siente insatisfecho, turbado, tenso.
22. Agitado, con tendencia a la preocupación, ansioso.
23. Tiene relaciones interpersonales superficiales.
24. Puede tener episodios periódicos de depresión.
25. Repite conductas en forma estereotipada.
26. Tiene mal pronóstico para psicoterapia, resistente a las interpretaciones en psicoterapia.
27. Puede terminar prematuramente la psicoterapia.
28. Se pone hostil y agresivo hacia el terapeuta
29. Puede ser un buen candidato para el litio.

Características de puntajes bajos en la escala 9

1. Tiene un nivel bajo de energía, bajo nivel de actividad, aletargamiento, distraído, apático, flemático.
2. Desmotivado
3. Confiable, responsable, se cuenta con él.
4. Convencional, práctico y racional.
5. Sincero, tranquilo, modesto, humilde.
6. Deprimido, ansioso, tenso, retraído.
7. No tiene confianza en sí mismo.
8. Sobre controlado, inhibido.
9. No es popular entre sus iguales.
10. Reporta fatiga crónica agotamiento físico.

Características asociadas con altos puntajes en escala Si (0) (inversión).

1. Socialmente introvertido.
2. Aislado.
3. Reservado, tímido, esquivo, retraído.
4. Se siente incómodo con los miembros del sexo opuesto
5. Difícil de conocer
6. Preocupado por la falta de contacto con la otra gente
7. Sensible a lo que piensan los demás
8. Falta de confianza en sí mismo.
9. Cauteloso, convencional, confiable, responsable, sumiso, complaciente.
10. Serio, lento, callado.
11. Sobre controlado, no le agrada manifestar sus sentimientos abiertamente.
12. Pasivo, exagerada aceptación de la autoridad.
13. Rigidez e inflexibilidad de pensamiento
14. Tiene dificultades en tomar decisiones, incluso pequeñas.
15. A menudo disfruta del trabajo, obtiene placer de los logros personales productivos.
16. Tendencias a preocuparse; irritable, ansioso.
17. Melancólico, tiene episodios de depresión.
18. Experimenta fuertes sentimientos de culpa.

Características de puntajes en SI (0) (Extroversión)

1. Sociable, extrovertido, gregario, amistoso, conversador.
2. Gusta de la vida social, no tiene problemas de contacto, conversador.
3. Activo, enérgico, vigoroso.
4. Tiene fuerte necesidad de estar rodeado de gente.
5. Inteligente, expresivo, con fluidez verbal, locuaz.
6. Interesado en el poder, status, reconocimiento, busca situaciones competitivas.
7. Manipulador, oportunista.
8. Puede tener problemas con el control de sus impulsos.
9. Puede actuar sin considerar la consecuencia de sus actos.
10. Crea resentimientos y hostilidad en los demás.
11. Tiene reacciones interpersonales superficiales y poco sinceras.
12. Inmaduro, auto – indulgente.
13. Espontáneo.

GLOSARIO

A

Abulia. Apatía y falta de fuerza de voluntad que incluye la falta de capacidad para tomar decisiones propias.

Aburrimiento. Estado emocional de insatisfacción en una persona que, durante ese período, es percibida como vacía y sin sentido.

Acting Out. Pasaje al acto.

Afasia. Alteración de la comprensión o transmisión de ideas mediante el lenguaje en cualquiera de sus formas (lectura, escritura o habla).

Afectividad. Emociones y sentimientos que un sujeto experimenta a través de las distintas situaciones que vive.

Afiliación. Mecanismo de defensa que se manifiesta cuando el sujeto busca ayuda o apoyo, compartiendo sus problemas sin tratar de atribuirlos a los demás.

Agitación. Estado de inquietud o de actividad permanente sin razón aparente.

Agresividad. Estado emocional manifestada por sentimientos de odio y deseos de agredir a otra persona, animal u objeto.

Alcoholismo. Conjunto de trastornos físicos y psíquicos ocasionados por el consumo excesivo y habitual de bebidas alcohólicas.

Alucinación. Percepción sensorial que tiene el concluyente sentido de la realidad de una percepción real, pero sin un objeto real (Ball)

Alucinógenos. Sustancias químicas o naturales que pueden provocar trastornos sensoriales, afectando a las emociones y el pensamiento (ilusiones y alucinaciones.)

Ambivalencia. El sujeto es simultáneamente atraído y repelido por la misma meta o deseo, generándole malestar emocional.

Angustia. Gran activación emocional que contiene un sentimiento de miedo o aprehensión. Miedo a lo desconocido.

Anorexia nerviosa. Trastorno alimenticio de orden psiquiátrico centrado en la negativa del enfermo a comer, conllevando una alarmante pérdida de peso.

Creencia de individuo de estar con sobrepeso, aunque la evidencia médica manifieste lo contrario.

Ansiedad. Miedo, temor y tensión, anticipados a padecer un daño o desgracia futuros.

A. P .A. American Psychiatric Association.

Apatía. Impasibilidad del ánimo. Estado en el que el sujeto permanece indiferente, y presenta una incapacidad para reaccionar ante situaciones que deberían suscitar emociones o intereses.

Atención. Facultad para centrarse en forma constante en un estímulo o actividad concretos.

B

Batería de test. Conjunto de tests o pruebas psicológicas destinadas para medir determinados aspectos de la psicología de una o varias personas (ver Test.)

Beneficio primario, secundario. Ventaja o provecho que el sujeto puede obtener ante la situación de padecer una enfermedad. El beneficio primario consiste en la disminución de una tensión interna o en la recuperación u obtención del afecto de un segundo (familia, amigos, pareja.) El secundario es más completo, puesto que la curación le plantearía problemas más angustiosos que su enfermedad. Esto se observa generalmente para evitar responsabilidades en el trabajo, u obtener dinero del seguro.

C

Catarsis. Liberación de la mente, a través de la palabra, de las ideas relegadas al inconsciente por un mecanismo de defensa.

Catatonía. Síndrome psicomotor que se caracteriza por la pérdida de iniciativa motriz, tensión muscular cataléptica, presencia de fenómenos paracinéti- cos, y un estado mental negativista y falta de motivación, y de estupor.

Cociente de inteligencia (C. I.) Número indicador del nivel de inteligencia de un individuo. Resulta de la división entre la edad medida por diferentes tests y la edad cronológica.

Cognición. Procesamiento consciente del pensamiento e imágenes.

Compulsión. Repetición innecesaria de actos, generada por un sentimiento de necesidad ajeno a la voluntad.

Convulsión. Contracción o espasmo muscular involuntario generalizado (Síndrome comicial.)

D

Delirium Tremens. Afecta a los alcohólicos que tras un prolongado periodo de consumo llegan a tolerar farmacológicamente el alcohol. Los síntomas del Delirium Tremens se manifiestan al interrumpir o disminuir considerablemente el consumo de alcohol, involucrando una serie de cambios mentales repentinos (Alucinaciones visuales terroríficas) y, cambios neurológicos como ser convulsiones.

Demencia. Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, anteriormente existentes.

Depresión. Sentimientos de impotencia, desesperanza, ineficiencia y tristeza. Pueden ser sintomáticos de varios trastornos, sin embargo, estos sentimientos también ocurren en las personas normales a partir de algún sucesos activador del mismo (pérdida de un familiar, accidente, etc,)

Despersonalización. Trastorno de la percepción, manifestado por la creencia del individuo de se siente separado del propio cuerpo o de los propios procesos mentales.

Desviación sexual. Anomalía en la elección del estímulo adecuado para la excitación sexual (parafilias.)

Diagnóstico. Interpretación que hace el especialista de la situación emocional de la persona, en función de sus manifestaciones verbales y actitud corporal, derivados de al problemática que refiere él mismo o sus allegados.

Dislexia. Dificultad para el aprendizaje de la lectura y escritura por consiguiente.

DSM- IV. Manual para el diagnóstico de enfermedades mentales.

E

Egocentrismo. Glorificación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales.

Egoísmo. Afecto excesivo hacia uno mismo, prefiriendo ante todo la conveniencia propia a la ajena.

Electroencefalograma. Registro gráfico de las descargas eléctricas producidas en las células cerebrales.

Esquizoide. Trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón vitalicio de indiferencia hacia los demás y de aislamiento social.

Esquizofrenia. Término concebido por E. Bleuler en 1908, el cual hace referencia a una grave enfermedad mental, caracterizada por la escisión o ruptura de la personalidad y de los mecanismos psíquicos normales, generando una conducta incomprensible, y pérdida del contacto con la realidad.

Estereotipados, movimientos. Repetición incansable de expresiones verbales, gestos y movimientos.

Estrés. Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en el individuo y que pida un cambio o acomodación por parte del mismo.

Estupor. Estado en el que no se responde a la estimulación y se acompaña de inmovilidad y mutismo.

Euforia. Estado de excitación psíquica que se acompaña de un alto tono afectivo.

Exaltación. Modificación del tono afectivo que se caracteriza por sentimientos de euforia.

F

Farmacoterapia. Tratamiento de las enfermedades y perturbaciones psíquicas a través de psicofármacos que estimulan o inhiben el sistema nervioso.

Fobia. Miedo o temor continuos e irracionales hacia un objeto, situación o actividad determinados. Esto suele conducir a evitar constantemente el estímulo fóbico o a afrontarlo con terror.

Forense, Psicología. Psicología Forense es una rama de la Psicología que utiliza sus conocimientos para fines legales, de investigación, psicodiagnóstico, mas no terapéuticos.

Fuga de ideas. Flujo casi continuo de habla precipitada y desorganizada, caracterizada por cambios temáticos bruscos, que habitualmente se basan en asociaciones comprensibles, estímulos que distraen la atención o juegos de palabras.

G

Hábito. Tendencia aprendida o adquirida a actuar de una manera mecánica y automática.

Hipocondría. Preocupación excesiva por la salud o por una enfermedad.

I

Idea delirante. Falsa creencia basada en una inferencia incorrecta relativa a la realidad externa que es firmemente sostenida por el individuo.

Idealización. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo atribuyendo cualidades exageradamente positivas a los demás.

Identidad. Concepto claro y nítido de uno mismo.

Identidad sexual. Convicción interna de una persona acerca de ser varón o mujer.

Ilusión. Reconocer erróneamente un estímulo real.

Inadaptación social. Estado en el que el sujeto establece unas relaciones conflictivas con su entorno social.

Inmadurez. Insuficiente grado de desarrollo afectivo que puede darse en personas cronológica e intelectualmente adultas.

Inteligencia. En líneas generales, capacidad mental para entender, recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en situaciones nuevas.

Intelectualización. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo generalizando o implicándose en pensamientos excesivamente abstractos para controlar o minimizar sentimientos que le causan malestar.

Introversión. Según Jung, característica del sujeto de naturaleza lenta, reflexiva y cerrada, que evita el contacto con los otros y se pone fácilmente a la defensiva.

Insight, capacidad de. Facultad para realizar una introspección madura.

Ítem. Pregunta o ejercicio de un test o prueba.

L

Labilidad. Estado emotivo caracterizado por una alteración del control consciente de las reacciones emotivas.

Logorrea. Locuacidad excesiva.

Lentitud psicomotora. Enlentecimiento generalizado visible de los movimientos y del habla.

M

MMPI Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Machover, test de la figura humana de. Creado por Karen Machover, esta prueba psicológica proyectiva evalúa la personalidad por medio del dibujo de la figura humana.

Manía. Enfermedad del estado de ánimo caracterizada por una hiperactividad psíquica y un fondo de alegría, de euforia y actividad frenética, que no tienen motivación real alguna.

Maníaco-depresiva, psicosis. Enfermedad mental caracterizada por la alternancia de fases maniacas y depresivas.

Marihuana. Denominación popular del extracto de una parte del *cannabis*, produce euforia y sensación de flotación.

Masoquismo. Trastorno psicosexual en el que la excitación sexual se consigue a través del dolor físico o la humillación infringida y/o solicitada por un miembro de la pareja a otro.

Masturbación. Autoestimulación de las zonas erógenas hasta llegar al climax.

Mecanismo de defensa. Proceso psicológico automático que protege al individuo de la ansiedad y de la conciencia de amenazas o peligros externos o internos.

Megalomanía. Sentimiento de potencia y superioridad que no tiene fundamentos reales.

Miedo. Reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en estado de conciencia.

Movimientos estereotipados. Comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y no funcional (p. ej., sacudir o mover las manos, balancear el cuerpo, golpear la cabeza, mordisquear objetos, automorderse, pincharse la piel o los orificios corporales, golpear el propio cuerpo).

N

Narcisismo. Sensación exagerada de importancia y preocupación extrema hacia uno mismo.

Narcolepsia. Tendencia irresistible al sueño.

Neurosis. Conjunto de síntomas psíquicos y emocionales derivados de un conflicto psicológico que se han hecho crónicos, manteniendo la capacidad de pensar racional y coherentemente.

O

Obsesión. Irrupción en el pensamiento de una idea, un sentimiento o una tendencia, que aparece en el enfermo en desacuerdo con su pensamiento consciente, pero que persiste a pesar de todos los esfuerzos que hace el sujeto por deshacerse de él.

Obsesivo-compulsiva, neurosis. Neurosis en las que las obsesiones y compulsiones se han hecho crónicas, perturbando la vida normal del sujeto.

Odio. Emoción reactiva frente a una persona o una vivencia que hiere o amenaza.

Oligofrenia. Ver Debilidad mental.

Olvido. Incapacidad del individuo para recordar un fragmento de información que está seguro que existe en su memoria.

P

Pánico. Episodio agudo de los estados de ansiedad caracterizado por un miedo intenso e irracional.

Paranoia. Delirio interpretativo que evoluciona de forma progresiva, con una lógica aparentemente perfecta y sin deterioro intelectual. La paranoia es raro que se establezca de forma pura, por eso es más conveniente hablar de personalidad paranoica, cuyos rasgos esenciales son una exagerada susceptibilidad, una hipervaloración del yo, desconfianza y una construcción mental peculiar.

Pedofilia. Trastorno psicosexual caracterizado por el interés erótico hacia los niños.

Pensamiento. Término genérico que indica un conjunto de actividades mentales tales como el razonamiento, la abstracción, la generalización, etc. cuyas finalidades son, entre otras, la resolución de problemas, la adopción de decisiones y la representación de la realidad externa.

Pensamiento mágico. Creencia errónea de que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto de un modo que desafía las leyes de causa y efecto comúnmente aceptadas. El pensamiento mágico puede formar parte del desarrollo normal del niño.

Percepción. Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto.

Perfil. Representación gráfica de los resultados de un test o batería de tests.

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de personalidad son aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia gama de contextos sociales y personales importantes. Los rasgos de personalidad sólo constituyen un trastorno de personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y provocan malestar subjetivo o déficit funcional significativo.

Psicofármaco. Sustancia química capaz de modificar el psiquismo normal o patológico.

Psicógeno. De origen psicológico.

Psicoterapia. Es cualquier proceso de reeducación que tiene por objeto ayudar a una persona con problemas, recurriendo fundamentalmente a las intervenciones psicológicas, en contraste con los tratamientos orgánicos, como la administración de drogas.

Psicótico. Este término ha recibido históricamente numerosas definiciones diferentes, ninguna de las cuales ha conseguido ser aceptada universalmente. La definición más estricta de psicótico se limita a ideas delirantes o alucinaciones prominentes, en ausencia de conciencia acerca de su naturaleza patológica. Una definición algo menos restrictiva también incluiría alucinaciones significativas que el individuo acepta como experiencias alucinatorias. Todavía es más amplia una definición que incluya asimismo otros síntomas positivos de esquizofrenia (esto es, habla desorganizada, comportamiento intensamente desorganizado o catatónico). Finalmente, el término ha sido definido conceptualmente como una pérdida de los límites del yo o una importante alteración de la verificación de la realidad.

Psicosis. Trastorno psíquico grave que afecta de un modo total a la personalidad y conducta del sujeto, con perturbación del juicio, de la voluntad y de la afectividad.

Psicosomático. Relativo, al mismo tiempo, tanto al componente psíquico o mental de la personalidad como al orgánico.

Psicoterapeuta. Especialista en Psicoterapia.

Psicoterapia. Conjunto de medios terapéuticos basados en la relación interpersonal; a través del diálogo, y las intervenciones del terapeuta, se posibilita la superación del conflicto psíquico.

R

Racionalización. Mecanismo de defensa que consiste en la justificación de hechos que no son aceptables para el propio sujeto, para de esta manera paliar su ansiedad. (La zorra y las uvas)

Rapport. Se dice que en una relación entre dos o más personas hay *rapport* cuando sus pensamientos o sentimientos armonizan entre sí o cuando presentan una serie de puntos de vista compartidos.

Represión. Mecanismo de defensa que consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o inaceptable para el sujeto. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo expulsando de su conciencia o no dándose por enterado cognoscitivamente de los deseos, pensamientos o experiencias que le causan malestar. El componente afectivo puede mantenerse activo en la conciencia, desprendido de sus ideas asociadas.

Reactivos. Ver ítems.

Rorschach, Láminas de tinta de. Prueba proyectiva creada por Herman Rosrchach que mide diversos aspectos de la personalidad. Compuesta por 10 láminas de manchas de tinta, es uno de los tests proyectivos más utilizados y difundidos desde su primera publicación en 1921.

S

Sadismo. Trastorno psicosexual en el que el sujeto obtiene placer del acto de infligir dolor y humillación a otra persona para satisfacer sus deseos sexuales.

Sedante. Sustancia que atenúa los estados de excitación emotiva o motriz.

Sensación. Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo exterior en los datos elementales o materia prima de la experiencia.

Síndrome. Agrupación de signos y síntomas basada en su frecuente coocurrencia, que puede sugerir una patogenia, una evolución, unos antecedentes familiares o una selección terapéutica comunes.

Suicidio. Consiste en quitarse voluntariamente la vida.

T

Test. Test (palabra inglesa que significa prueba y que fue introducida por Cattell en 1890) es un reactivo que, aplicado a un sujeto, revela y da testimonio del tipo o grado de su aptitud, personalidad o del grado de instrucción que posee.

Temperamento. Es la conformación reactiva de un individuo, el aspecto espontáneo de su personalidad. Procede de la combinación de disposiciones características emanadas de sus apetitos, emociones y estados de ánimo.

Timidez. Tendencia por parte de la persona a sentirse incómodo, inhibido, torpe y muy consciente de sí mismo en presencia de otras personas. Esto produce incapacidad para participar en la vida social, aunque se desee hacerlo y se sepa cómo.

Toxicomanía. Uso habitual y dañino de tóxicos, drogas o estupefacientes. Se acompaña generalmente de una dependencia psíquica y a veces también física.

Trastorno de la personalidad. Es un tipo de trastorno conductual que se caracteriza por provocar considerables problemas para la adaptación social. La persona que padece el trastorno de personalidad no siempre ni forzosamente se siente perturbada, pero en cambio los demás a menudo la consideran perturbadora o molesta.

Trastorno mental orgánico. Es aquel en el cual un estado patológico del cuerpo, en particular el cerebro y el sistema nervioso, genera una conducta inadaptada.

V

Validez. En psicología, el concepto de validez se aplica fundamentalmente a los tests psicológicos estandarizados. Se dice que un test es válido si mide lo que se supone que debe de medir.

Voluntad. La facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un determinado acto. Depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto en concreto.

X

Xenofobia. Prejuicios con recelo, odio, hostilidad, fobia y rechazo contra los grupos étnicos diferentes, cuya fisionomía social y cultural se desconoce.

Y

Yo (*ego*). Término psicoanalítico que según Freud, se centra en el "principio de realidad", es consciente y tiene la función de la comprobación de la realidad, así como la regulación y control de los deseos e impulsos provenientes del Ello. Su fin principal es la autoconservación del sujeto, utilizando todos los mecanismos psicológicos de defensa.

Z

Zoofilia. Desviación de la fuente de atracción sexual, en la que la excitación se obtiene con animales.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALVARADO, José María, *"Psiquiatría Forense"*, OFFSET PRISA PUBLICIDAD, La Paz – Bolivia 1993.

BRENLLA, Maria Elena *et al*, *Evaluación de la Personalidad*, PSICOTECA EDITORIAL, Argentina 1992.

Diccionario de psicoanálisis

Diccionario de Psicología

GRAHAM, J. R., *"MMPI. Guía Práctica"*, MANUAL MODERNO, México 1999.

GRAHAM, *MMPI Guía Práctica*, Editorial El Manual Moderno, México, 1999.

HATHAWAY – MCKINLEY, *Cuestionario de la Personalidad MMPI*, EDICIONES TEA, España 1975.

HIGUERAS, Aranda Antonio y cols. Compendio de Sicopatología. Círculo de estudios psicopatológicos. 3 ° Edición. Granada – España. 1986.

NUÑEZ DE ARCO, Jorge, *"El informe pericial en psiquiatría forense"*, MAVA PRODUCCIONES GRAFICAS, La Paz – Bolivia 2001, Pg 137.

RICE, Phillip, *Desarrollo Humano*, PRENTICE – HALL HISPANOAMERICANA S.A, México, 1997.